

Вариативное меню в стационарных организациях социального обслуживания: право, данные, практика

Аналитический доклад. Вторая, расширенная и переработанная редакция

Е. В. Чистяков, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

5 октября 2026 г.

Содержание

Сведения о документе.....	5
Аннотация.....	6
Сокращения.....	7
Введение	8
1 Понятия и разграничения	10
1.1 Учреждения: два правовых режима одного стола	10
1.2 Четыре словаря	11
1.3 Три определения в разных слоях материалов	11
1.4 Три шкалы, которые нельзя склеивать.....	12
1.5 Питание как социальная услуга	13
1.6 Краткая история регулирования	14
2 Федеральное право	15
2.1 Конституционные и международные основания	15
2.2 Закон № 442-ФЗ.....	15
2.3 Примерный порядок (приказ № 935н).....	16
2.4 Правила организации деятельности (приказ № 305н).....	16
2.5 Нормы питания: приказ № 520н и методические рекомендации 2002 г.....	18
2.6 Таблица замен: где она находится в праве	20
2.7 Санитарные правила: переход от СанПиН 3590-20 к СанПиН 4282-26.....	21
2.8 Лечебное питание: граница компетенций	23
2.9 Закон № 3185-1 и питание в ПНИ	24
2.10 Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ	24
2.11 Ответственность.....	25
2.12 Итог по федеральному уровню	25
3 Региональные нормы питания	27
3.1 Архитектура регионального регулирования	27
3.2 Санкт-Петербург: постановление № 1284.....	27
3.3 Москва	31
3.4 Свердловская область	32
3.5 Нижегородская область	32
3.6 Омская область	32
3.7 Псковская область	32
3.8 Другие субъекты	33
3.9 Республика Татарстан: пример из здравоохранения.....	33
3.10 Сравнение.....	33
3.11 Что региональные нормы дают выбору	34

4 Российские практики: что известно из открытых источников.....	35
4.1 Метод и ограничения	35
4.2 Болотнинский психоневрологический интернат (Новосибирская область).....	35
4.3 Успенский психоневрологический интернат (Новосибирская область)	36
4.4 Каменский психоневрологический интернат (Новосибирская область)	36
4.5 Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область).....	37
4.6 Иркутская область: региональное сообщение и Чунский ДСО	38
4.7 Красавинский дом социального обслуживания (Вологодская область).....	38
4.8 ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург).....	39
4.9 «Добрый дом „Солнечногорский“» (Московская область)	40
4.10 Сводная таблица	40
4.11 Что следует из совокупности кейсов	41
5 Научные данные	43
5.1 Зачем доклад о праве обращается к исследованиям.....	43
5.2 Масштаб проблемы: недостаточность питания в учреждениях.....	43
5.3 Выбор и удовлетворённость.....	44
5.4 Выбор, среда приёма пищи и пищевой статус.....	45
5.5 Выбор и люди с тяжёлыми психическими расстройствами	45
5.6 Международные клинические рекомендации	46
5.7 Отходы с тарелки как измеритель	47
5.8 Текстуры и ограничения выбора	47
5.9 Организационные факторы	47
5.10 Стоимость	48
5.11 Чего наука не знает	48
5.12 Сводная таблица	48
6 Зарубежное регулирование.....	50
6.1 Зачем и с какой осторожностью.....	50
6.2 Англия: регламент CQC	50
6.3 Шотландия: стандарты здравоохранения и социального ухода	50
6.4 США: федеральные требования к домам сестринского ухода	51
6.5 Канада, Онтарио: регламент о долговременном уходе.....	51
6.6 Австралия: усиленные стандарты качества	52
6.7 Германия и Австрия: стандарты профессиональных обществ.....	52
6.8 Швеция и Япония.....	52
6.9 Сводная таблица	53
6.10 Выводы для российской дискуссии	53
7 Практика: десять операционных сценариев.....	55
7.1 Как читать раздел.....	55
7.2 Сценарий 1. Два вторых блюда в пределах нормы № 1284.....	55

7.3 Сценарий 2. Пары внутри одной группы продуктов	56
7.4 Сценарий 3. Заказ накануне или выбор в момент еды	56
7.5 Сценарий 4. Раздача и персонал	57
7.6 Сценарий 5. Санитарный паспорт каждого варианта	58
7.7 Сценарий 6. Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ	58
7.8 Сценарий 7. Комплект документов для проверяющего.....	59
7.9 Сценарий 8. Экономика: что можно утверждать и как измерять	60
7.10 Сценарий 9. Пилот на 90 дней.....	61
7.11 Сценарий 10. Невербальный выбор, отказ, пост и ночной интервал.....	62
7.12 Инструменты измерения: что существует и что из этого применимо	63
8 Контроль: кто и что проверяет.....	66
8.1 Различие предметов контроля.....	66
8.2 Санитарно-эпидемиологический надзор	66
8.3 Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания	66
8.4 Учредитель.....	66
8.5 Прокуратура	67
8.6 Антимонопольный контроль.....	67
8.7 Независимая оценка и общественный контроль	67
8.8 Внутренний контроль.....	67
8.9 Сводка.....	68
9 Противоречия и нерешённые вопросы	69
9.1 Принцип.....	69
9.2 Перечень	69
9.3 Что из этого следует для читателя.....	73
10 Предложения.....	74
10.1 Федеральный уровень.....	74
10.2 Региональный уровень	75
10.3 Уровень учреждения	75
11 Заключение.....	76
Список источников.....	78
Приложение А. Реестр нормативных и иных актов	87
Приложение Б. Нормы постановления № 1284: все столбцы для взрослых	91
Приложение В. Изменения по сравнению с первой редакцией	93

Сведения о документе

Статус. Аналитический доклад автора. Не является официальным толкованием законодательства, не выражает позицию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, его рабочей группы по вариативному меню или Правительства Санкт-Петербурга. Предложения раздела 10 — авторские рекомендации, а не изложение действующих норм.

Отношение к первой редакции. Доклад перерабатывает правовой обзор «Вариативное меню: НПА» (литературная редакция 29.08.2026, данные проверены на 16.07.2026; папка raw/sources/variativnoe-menu-npa-2026/ репозитория) [1]. Из первой редакции сохранены региональный анализ и часть источников; исправлены выявленные ошибки (их перечень — приложение В); добавлены разделы о научных данных, зарубежных нормах, российских кейсах и практических сценариях. Где первая редакция и настоящая расходятся, расхождение названо в тексте.

Дата актуальности. Нормативные акты сверены по открытым источникам на 05.10.2026. Санитарные требования приводятся в двух слоях: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — для периода до 31.08.2026 включительно (в том числе для материалов семинара 25–27.08.2026); СанПиН 2.3/2.4.4282-26 — с 01.09.2026 [2, 3].

Классы утверждений. Каждое существенное утверждение относится к одному из четырёх классов; класс обозначается в тексте, если не очевиден из контекста.

Класс	Что означает	Пример
Норма	Обязательное правило, установленное нормативным правовым актом; указаны акт и структурная единица	«Не менее трёх приёмов пищи в день» — подп. 11 п. 56 СанПиН 4282-26
Толкование	Вывод автора из текста нормы; может оспариваться	«Выбор блюда не запрещён, поскольку ни один акт его не ограничивает»
Рекомендация	Методический документ, научное руководство или предложение автора; не обязательно	ESPEN; методические рекомендации 2002 г.; раздел 10 доклада
Локальная форма	Акт или документ конкретного учреждения; обязателен только в нём	Приказ ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124

Источники нумеруются в квадратных скобках; список — в конце доклада. Иллюстративные расчёты помечены словами «иллюстративная арифметика» и не являются данными учреждений.

Аннотация

Доклад исследует правовые, организационные и доказательные основания вариативного меню — организации питания, при которой проживающий в стационарной организации социального обслуживания в момент приёма пищи располагает не менее чем двумя вариантами блюда и влияет на то, какой получит. Объект исследования — дома социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) и психоневрологические интернаты Российской Федерации; предмет — нормы, которые определяют, что, сколько и как подаётся на стол, и пространство, которое эти нормы оставляют выбору.

Проанализированы федеральные законы и подзаконные акты (в том числе не учтённые в первой редакции приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н и Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, утверждённые приказом Минтруда России от 14.05.2025 № 305н, а также СанПиН 2.3/2.4.4282-26, вступивший в силу 01.09.2026), региональные нормы питания девяти субъектов с подробным разбором постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284, практики восьми российских учреждений, описанные в открытых источниках, нормы девяти зарубежных систем и научная литература о недостаточности питания, выборе блюд, форме подачи и пищевых отходах в учреждениях длительного ухода.

Основные выводы. Ни федеральное, ни проанализированное региональное право не закрепляет понятия вариативного меню и не ограничивает число вариантов блюда. Механизм эквивалентной замены продуктов, на который принято ссылаться как на правовую основу выбора, для взрослых закреплён только в методических рекомендациях 2002 г., ссылающихся на приказ Минторга СССР 1980 г.; таблица замен санитарных правил формально помещена в раздел о питании детей. Научные данные о выборе блюд в учреждениях ухода за пожилыми получены преимущественно в пилотных и наблюдательных исследованиях; они согласованно показывают рост удовлетворённости и неоднозначное влияние на потребление и затраты. Рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях социального обслуживания не найдено. Опубликованные российские практики описывают факт внедрения, но не его результаты. В практической части разобраны сценарии: два горячих блюда в пределах норм № 1284, санитарный контур второго варианта по СанПиН 4282-26, закупка по 44-ФЗ и 223-ФЗ, раздача лежачим, комплект документов для проверки, расчёт затрат и замер отходов.

Ключевые слова: вариативное меню; социальное обслуживание; приказ Минтруда № 305н; дом-интернат; психоневрологический интернат; нормы питания; СанПиН 2.3/2.4.4282-26; приказ Минтруда № 520н; выбор блюд; недостаточность питания; пищевые отходы.

Сокращения

Сокращение	Расшифровка
44-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
223-ФЗ	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
442-ФЗ	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
3185-1	Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»
ДСО	дом социального обслуживания (в Санкт-Петербурге — наименование ряда бывших домов-интернатов и ПНИ)
ИППСУ	индивидуальная программа предоставления социальных услуг
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КПИ	Конвенция ООН о правах инвалидов
ПНИ	психоневрологический интернат
РГ	рабочая группа Минтруда России по вариативному меню
СанПиН 3590-20	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (действовал до 31.08.2026)
СанПиН 4282-26	СанПиН 2.3/2.4.4282-26 с тем же названием (действует с 01.09.2026 до 01.09.2032)
СБКС	смесь белковая композитная сухая
ТТК	технико-технологическая карта
ESPEN	European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
М0–М5	модели организации раздачи (ось технологии стола), см. п. 1.4
Ступени 0–5	ступени участия жителя (ось контроля над едой), см. п. 1.4

Введение

Проблема. Только в психоневрологических интернатах России, по подсчёту проекта «Если быть точным», на 2024 г. было 466 учреждений и около 139 тыс. жителей, из которых 74 % признаны недееспособными [4]; к ним добавляются жители домов-интернатов общего типа, общее число которых в использованных источниках с проверяемыми реквизитами не найдено. Еда — повторяющаяся несколько раз в день часть их жизни, в которой выбор технически возможен. Тем не менее типовая организация питания в этих учреждениях устроена как обеспечение: регион утверждает суточный набор продуктов в граммах, пищеблок составляет цикличное меню и меню-раскладку, отделение получает одинаковые порции. Выбор в этой конструкции не запрещён, но и не предусмотрен. Он появляется там, где учреждение само решает его ввести, и исчезает, когда уходит инициатор.

С 2024 г. в открытых источниках появились сообщения о внедрении вариативного питания в психоневрологических интернатах Новосибирской области, в учреждениях Иркутской области и в ДСО «Серафимовский» Санкт-Петербурга [5–15]. В 2026 г. тема стала предметом работы рабочей группы Минтруда России и межрегионального семинара 25–27.08.2026. Практический вопрос директора звучит просто: можно ли подавать два вторых блюда, не нарушив нормы питания, санитарные правила и закупочное законодательство, и что для этого нужно иметь в папке на случай проверки. Ответ на него не помещается в одну строку, потому что три нормативных слоя — социальный, санитарный и закупочный — написаны независимо друг от друга и о выборе молчат.

Цель доклада — установить, какие нормы действующего права определяют организацию питания в стационарных организациях социального обслуживания, какое пространство они оставляют выбору блюд, что известно о последствиях выбора из научных исследований и практики, и предложить проверяемые организационные решения, не выдавая их за нормы.

Задачи:

1. развести понятия, которые в отраслевой речи смешиваются (цикличное меню, вариативное меню, таблица замен, персонализация питания), и шкалы, которыми описывают внедрение;
2. проанализировать федеральные акты, включая изменения 2022–2026 гг., и установить, где именно в праве находится механизм эквивалентной замены;
3. сопоставить региональные нормы питания, прежде всего постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1284;
4. описать российские практики с указанием того, что источник сообщает и чего не сообщает;
5. обобщить научные данные и зарубежные нормы о выборе блюд в учреждениях длительного ухода;
6. разобрать практические сценарии внедрения с опорой на действующие нормы;

7. перечислить противоречия и пробелы и сформулировать предложения с явной пометкой их статуса.

Методы и источники. Использован формально-юридический анализ текстов нормативных актов в действующих редакциях (официальные публикации, справочные системы «Гарант», «КонсультантПлюс», ведомственные сайты); сравнительно-правовой анализ региональных и зарубежных норм; структурированный поиск научной литературы в Europe PMC/PubMed и eLIBRARY/КиберЛенинке по запросам о выборе блюд, удовлетворённости питанием, форме подачи, недостаточности питания и пищевых отходах в учреждениях длительного ухода (поиск выполнен 05.10.2026; это целевой, а не систематический обзор); анализ публичных сообщений учреждений и органов власти. В качестве вторичной базы использованы материалы репозитория семинара: первая редакция обзора [1], доклад «Не просто накормить» и сопровождающая его база знаний с реестром противоречий [16, 17]. Утверждения этих материалов перепроверялись по первоисточникам; где перепроверка не удалась, это оговорено.

Ограничения. Доклад не содержит назначений диет, текстур или лечебного питания: эти решения принимает врач, и доклад их не подменяет. Сведения о практике учреждений взяты из их публичных сообщений и не являются результатами аудита. Данные о стоимости питания приводятся только по опубликованным источникам; расчёты без источника помечены как иллюстративные. Тексты ряда региональных актов изучены по первой редакции обзора и повторно не сверялись; это указано при их изложении.

Что нового во второй редакции. По сравнению с первой редакцией [1]: (а) введён в анализ приказ Минтруда России № 520н — действующие федеральные рекомендуемые нормы питания; (б) санитарный блок переписан под СанПиН 4282-26 с постановочным сопоставлением; (в) установлено, что таблица замен СанПиН относится к разделу о питании детей, а нормы взаимозаменяемости методических рекомендаций 2002 г. содержатся в приложении № 7, а не № 6; (г) добавлен анализ Закона № 3185-1 для ПНИ; (д) исправлены ссылки на ограничение платы в 75 % и на статьи КоАП; (е) добавлены разделы о научных данных (около двадцати исследований и руководств), зарубежных нормах и шести российских кейсах; (ж) практическая часть расширена до десяти сценариев. Полный перечень изменений — в приложении В.

1 Понятия и разграничения

1.1 Учреждения: два правовых режима одного стола

Стационарная форма социального обслуживания определена 442-ФЗ как предоставление социальных услуг при постоянном, временном или пятидневном круглосуточном проживании получателя в организации [18; 19, п. 11]. Внутри этой формы различаются два типа учреждений, и для темы доклада различие существенно.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов действуют в режиме 442-ФЗ: права получателя определяются ст. 9 закона, объём услуг — индивидуальной программой и договором (ст. 16, 17), нормы питания — актом субъекта (ст. 8).

Психоневрологические интернаты подчиняются тому же закону, но к ним дополнительно применяется Закон № 3185-1. Его ст. 43 распространяет на лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, права, предусмотренные частями второй и четвёртой ст. 37, а обязанности организации по созданию условий для их реализации относит к ст. 39 и законодательству о социальном обслуживании [20]. Среди прав ч. 2 ст. 37 — право «исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост», если это не нарушает внутренний распорядок [20]. Это единственная найденная норма федерального закона, которая прямо касается содержания тарелки проживающего: соблюдение поста — право жителя ПНИ, а не милость кухни. С 01.09.2025 аналогичная обязанность на уровне подзаконного акта распространена на все организации социального обслуживания: Правила, утверждённые приказом Минтруда России № 305н, обязывают их «обеспечивать условия для исполнения религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в том числе постов» (подп. 15 п. 20) [21] (подробнее — п. 2.4). Первая редакция обзора Закон № 3185-1 не упоминала [1]; для ПНИ это существенный пропуск.

Переименование ПНИ в дома социального обслуживания, проведённое, по данным «Если быть точным», к концу 2025 г. как минимум в 41 регионе [4], имеет федеральное основание: Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, действующие с 01.09.2025, называют среди видов стационарных организаций дом социального обслуживания, специальный дом-интернат и иные организации (п. 29), но не психоневрологический интернат [21]. Правового режима, определяемого Законом № 3185-1, переименование само по себе не меняет. В Санкт-Петербурге, по сообщению Комитета по социальной политике от 22.07.2025, психоневрологических интернатов больше нет: все они переименованы в дома социального обслуживания, и ведётся актуализация их уставов [15]. Сайт ДСО «Серафимовский» до прекращения работы располагался на домене pn19.ru [22]. Для применения ст. 43 Закона № 3185-1 значимо назначение организации, а не вывеска. В ДСО, где живут люди без психиатрического диагноза, опорой остаётся 442-ФЗ. Поэтому решения, разобранные в разделе 7, для ПНИ проверяются по двум законам, для дома-интерната общего типа — по одному.

1.2 Четыре словаря

В отраслевой речи под «вариативным меню» понимают по меньшей мере четыре разных явления. Их смешение — главный источник споров с проверяющими и с самими собой.

Цикличное меню — разнообразие во времени: набор блюд повторяется через 7, 10, 14 или 21 день. Цикличное меню обязательно в силу санитарных правил для детских организаций (не менее двух недель, п. 59 подп. 4 СанПиН 4282-26 [3]) и сложилось как практика во взрослых учреждениях. Жителю оно ничего не предлагает выбрать: «четырнадцать дней без повторов» — характеристика меню, а не свобода человека.

Таблица замен (нормы взаимозаменяемости) — инструмент склада и раскладки: при отсутствии продукта он заменяется другим в эквивалентном по пищевой ценности количестве. Таблица защищает норму, а не выбор. Гречка, заменённая рисом «по остаткам», — замена, а не вариант. Где именно таблица замен находится в праве для взрослых — отдельный вопрос, разобранный в п. 2.6.

Персонализация питания — индивидуальные решения по медицинским показаниям: диета, консистенция, обогащение, режим. Её основание — назначение врача; кухня его исполняет. Персонализация не является выбором в смысле доклада и не должна им подменяться: житель с назначенной протёртой пищей имеет право на выбор среди протёртых блюд, но не на отмену назначения через «выбор».

Вариативное меню — организация питания, при которой житель в момент приёма пищи располагает не менее чем двумя вариантами блюда и влияет на то, какой получит. Это определение (толкование) принято в докладе «Не просто накормить» [16] и используется здесь как основное.

Четыре словаря можно проверить одним вопросом: что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня и кто это решил? Если решили регион и кухня — это цикл или замена. Если решил врач — персонализация. Если решил сам житель (или, при невозможности сказать, по наблюдаемым признакам его воли) — выбор.

1.3 Три определения в разных слоях материалов

Определения вариативного меню в материалах, на которые опирается доклад, не совпадают, и это расхождение следует видеть.

Слой	Определение (в пересказе)	Охват
«Не просто накормить», гл. 8.1 [16]	В момент еды у жителя не менее двух вариантов, и он влияет на то, какой получит	Узкое

Слой	Определение (в пересказе)	Охват
Обзор НПА, § 1.2 [1]	Проживающему на каждый приём пищи (или на основные приёмы) предлагают выбор из двух и более вариантов блюд, гарниров, салатов или напитков в рамках утверждённых норм, «либо дают возможность заказать блюдо заранее из утверждённого ассортимента»	Шире: включает заказ на любой срок вперёд
Предшествующий доклад семинара, гл. 4.1 [17]	Любое расширение выбора — от напитка до полной индивидуализации	Самое широкое

Узкое определение удобно для проверки: его выполнение видно в журнале и на линии раздачи. Широкое удобно для отчёта: под него подпадает почти любое изменение. Доклад использует узкое определение и отдельно оговаривает, когда речь идёт о предварительном заказе. Заказ накануне (так устроена практика ДСО «Серафимовский» [15]) по узкому определению является выбором при условии, что заказанное блюдо фактически подаётся заказавшему; заказ на неделю вперёд — выбор с отсрочкой, при котором право изменить решение в день подачи становится отдельным вопросом.

1.4 Три шкалы, которые нельзя склеивать

Для описания степени внедрения в материалах семинара используются три независимые шкалы.

Модели раздачи М0–М5 — ось технологии стола [16, 17]:

Модель	Содержание	Публичные российские примеры
М0	Мономеню; при отказе — замена по таблице; остатки влияют на цикл	Фундамент, не вариативность
М1	Второй вариант одной ключевой позиции, не каждый день	Болотнинский ПНИ [5]; ДСО «Серафимовский» (заказ накануне) [15]
М2	Два варианта основных позиций ежедневно	Успенский ПНИ [7]; сообщение по Иркутской области [11]
М3	Житель сам комплектует тарелку на линии	Линия самообслуживания ДДСОЛ [23]
М4	Семейная подача: блюда на столе, жители накладывают сами	Зарубежные исследования [24]; в России публично не описано
М5	Жители готовят сами (учебная квартира)	Сопровождаемое проживание; не массовая модель

Ступени участия 0–5 — ось жителя: насколько контроль над едой возвращён человеку (0 — еду определили регион, кухня и смена; 1 — спросили, тарелка та же; 2 — выбор дошёл до тарелки; 3 — добавились время и место; 4 — житель влияет на меню через совет; 5 — еда снова часть жизни, а не процедуры) [16, 17].

Пять моделей обзора НПА (§ 4.2) — организационные формы: двухвариантное меню; меню-заказ на неделю; шведский стол; смешанная модель (выбор несколько раз в неделю); событийная (праздничные меню) [1].

Шкалы измеряют разное. Дом может работать по М2 (два вторых ежедневно), а жители отделения милосердия при этом остаются на ступени 0, если выбор существует только в столовой, куда они не спускаются. Нумерации не совпадают: «модель 1» обзора НПА не равна М1, «ступень 2» не равна М2. В первой редакции обзора Болотнинский ПНИ одновременно отнесён к модели 1 и модели 4 [1]; по шкале М0–М5 это М1, а по пятичленной шкале обзора — смешанная модель (выбор несколько раз в неделю). В настоящем докладе шкала моделей обзора НПА не используется, кроме цитирования.

1.5 Питание как социальная услуга

Обеспечение питанием относится к социально-бытовым услугам, перечень которых устанавливает субъект Российской Федерации на основании ст. 8 и ст. 20 442-ФЗ [18]. Федеральный Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме (приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н) задаёт два положения, прямо касающихся питания [19]:

- при расчёте объёма услуг учитываются нормы и нормативы, в том числе нормы питания, установленные в соответствии с 442-ФЗ; если нормы не установлены, объём услуги не может быть меньше предусмотренного индивидуальной программой и договором (п. 16) — **норма**;
- при оценке качества социально-бытовых услуг оценивается питание, «которое должно быть приготовлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам» (подп. 5 п. 19) — **норма**.

В том же п. 19 есть показательное соседство. Мягкий инвентарь должен соответствовать «по возможности, их запросам по фасону и расцветке» (подп. 4) [19]. Предпочтения получателя федеральный критерий качества учитывает для одежды, но не для еды: питание оценивается по доброкачественности, калорийности и соответствию нормам. Отсюда не следует, что учитывать вкус запрещено. Следует только то, что федеральный критерий качества его не требует, и учреждение, вводящее выбор блюд, опирается не на п. 19, а на общие права получателя (ст. 9 442-ФЗ) и на свои локальные акты (толкование).

1.6 Краткая история регулирования

Хронология важна потому, что в действующей практике одновременно применяются документы пяти десятилетий.

Год	Акт	Значение для темы
1980	Приказ Минторга СССР от 12.12.1980 № 310	Нормы взаимозаменяемости продуктов; извлечение из него до сих пор приложено к методическим рекомендациям 2002 г. [25]
1992	Закон РФ № 3185-1	Права жителей ПНИ, включая соблюдение поста (ст. 37, 43) [20]
2002	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12	Методические рекомендации по организации питания; рекомендуемые наборы, меню-раскладки для ПНИ и прочих учреждений, нормы взаимозаменяемости [25]
2007	Приказ Минздравсоцразвития от 04.06.2007 № 397	Новая редакция рекомендаций 2002 г. [25]
2013	442-ФЗ	Нормы питания утверждает субъект (ст. 8) [18]
2014	Приказы Минтруда № 552н и № 935н	Первые федеральные рекомендуемые нормы питания; Примерный порядок [19, 26]
2014	Постановление Правительства СПб № 1284	Нормы питания Санкт-Петербурга с 01.01.2015 [27]
2020	СанПиН 3590-20	Единые санитарные требования к общественному питанию, в том числе в организациях социального обслуживания [2]
2022	Приказ Минтруда № 520н	Новые рекомендуемые нормы; № 552н утратил силу [26]
2025	Приказ Минтруда от 14.05.2025 № 305н	Правила организации деятельности организаций социального обслуживания с 01.09.2025 (вместо приказа № 940н 2014 г.); обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов; ПНИ нет в перечне видов организаций [21]
2026	СанПиН 4282-26	С 01.09.2026 заменяет СанПиН 3590-20 без переходного периода [3]

Первая редакция обзора построила федеральный методический блок на постановлении № 12 от 2002 г. и назвала его «действующим, но морально устаревшим» [1]. Приказ № 520н, принятый двадцатью годами позже, в ней не упомянут. Номер «774н», встречающийся в одном из академических слоёв материалов семинара [17], по открытым источникам не подтверждён и в докладе не используется.

2 Федеральное право

2.1 Конституционные и международные основания

Конституция Российской Федерации не говорит о питании прямо. Для темы значимы три её положения: охрана достоинства личности, которое ничто не может умалять (ст. 21), социальное государство, гарантирующее государственную поддержку пожилых граждан и инвалидов (ст. 7, 39), и право на охрану здоровья (ст. 41) [28]. Из них не выводится право на два вторых блюда; выводится требование, чтобы ограничения в повседневной жизни проживающего имели основание, а не возникали из удобства организации (толкование).

Конвенция ООН о правах инвалидов, ратифицированная Россией в 2012 г., содержит три относящиеся к делу нормы: право на самостоятельный образ жизни и вовлечённость в местное сообщество (ст. 19), на здоровье (ст. 25) и на достаточный жизненный уровень, «включающий достаточное питание» (ст. 28) [29]. Комитет ООН по правам инвалидов в Замечании общего порядка № 1 (2014) к ст. 12 разъяснил, что замещающее принятие решений должно уступать место поддерживаемому [30]. Для ПНИ, где большинство жителей признаны недееспособными [4], это означает, что вопрос «может ли этот человек выбрать» должен ставиться как вопрос «какая поддержка ему нужна, чтобы выбор был его», а не решаться признанием недееспособности (толкование; правовые последствия Замечания для российских судов не исследуются).

2.2 Закон № 442-ФЗ

442-ФЗ распределяет полномочия так, что содержание тарелки определяет субъект. Органы государственной власти субъекта утверждают нормы питания в организациях социального обслуживания (ст. 8), перечень социальных услуг, порядок их предоставления и тарифы [18] — **норма**. Федеральный центр устанавливает примерный порядок (приказ № 935н) и рекомендуемые нормы питания (приказ № 520н), но регион не обязан их повторять (толкование, основанное на рекомендательном характере обоих актов).

Для выбора блюд значимы следующие положения закона [18] — **нормы**:

- социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства (ч. 1 ст. 4);
- получатель имеет право на уважительное и гуманное отношение, на бесплатное получение в доступной форме информации о своих правах, о видах и условиях социальных услуг, на отказ от предоставления социальных услуг, на участие в составлении индивидуальной программы, на условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, и на надлежащий уход (ст. 9);
- индивидуальная программа определяет форму, вид, объём, периодичность и условия предоставления услуг (ст. 16), договор — их состав и стоимость (ст. 17);

- размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание рассчитывается на основе тарифов, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода получателя (ч. 4 ст. 32).

О последнем положении в материалах семинара существуют две ссылки: доклад «Не просто накормить» относит ограничение в 75 % к ч. 4 ст. 32 442-ФЗ, первая редакция обзора — к п. 35 приказа № 935н [1, 16]. Проверка текстов показала, что правы обе: п. 35 Примерного порядка дословно воспроизводит законодательное ограничение [19]. Источником нормы является закон; приказ её повторяет. Противоречия нет, есть разная глубина ссылки.

Для вариативного меню важнее другое. Право на отказ от услуги (ст. 9) охватывает отказ от конкретного блюда (толкование), но закон не говорит, что учреждение должно предложить взамен. Право на участие в составлении ИППСУ позволяет внести в программу пищевые предпочтения, но федеральная форма программы для этого не предназначена; прямого права на ежедневный выбор блюда закон не содержит [17]. Выбор в 442-ФЗ возможен, но не гарантирован.

2.3 Примерный порядок (приказ № 935н)

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н утверждает Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме [19]. Он устанавливает, что объём услуг рассчитывается с учётом норм питания (п. 16), а качество социально-бытовых услуг оценивается, в частности, по питанию из доброкачественных продуктов, удовлетворяющему потребности по калорийности и соответствующему нормам и санитарным требованиям (подп. 5 п. 19). Критерии полноты, своевременности и результативности (п. 18) общие для всех услуг. Как показано в п. 1.5, критерий качества упоминает «запросы» получателя применительно к одежде, но не к питанию.

Статус приказа требует точности: Примерный порядок — ориентир для субъектов, а не прямой регулятор учреждения. Порядок предоставления услуг утверждает субъект (ст. 8 442-ФЗ) [18]. Поэтому ссылка «по п. 19 приказа № 935н питание должно быть разнообразным» неверна дважды: пункт этого не говорит, и учреждение подчиняется региональному порядку (толкование).

2.4 Правила организации деятельности (приказ № 305н)

С 01.09.2025 действуют Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утверждённые приказом Минтруда России от 14.05.2025 № 305н (зарегистрирован Минюстом России 02.06.2025 № 82485; действует до 01.09.2031) [21]. Приказ издан на основании п. 6 ч. 2 ст. 7 442-ФЗ и признал утратившим силу приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н с изменениями. Ни первая редакция обзора, ни предшествующие материалы семинара этот акт не рассматривали [1, 16, 17], хотя для темы он значим больше, чем Примерный порядок: в отличие от приказа № 935н, Правила обращены непосредственно к организациям, а не к субъектам как образец.

Для питания и выбора существенны четыре группы положений — **нормы**, если не указано иное:

- нормы питания в организациях, находящихся в ведении субъекта, устанавливаются актами субъекта в рамках полномочий по ст. 8 442-ФЗ (п. 15) — федеральный акт подтверждает распределение компетенции, а не вводит собственных норм;
- организация обязана предоставлять услуги в соответствии с индивидуальными программами и договорами (подп. 2 п. 20), бесплатно и в доступной форме информировать получателей о видах, порядке и условиях услуг (подп. 4 п. 20), создавать «комфортные безопасные условия пребывания», в том числе в помещениях для принятия пищи (подп. 13 п. 20), и размещать получателей в спальнях с учётом пола, возраста, «интересов и предпочтений, личностных особенностей» (подп. 10 п. 20);
- организация обязана «обеспечивать условия для исполнения религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в том числе постов» (подп. 15 п. 20) — для всех организаций социального обслуживания, а не только для ПНИ, как по ст. 43 Закона № 3185-1;
- стационарные организации создаются для разнополого состава получателей и подразделяются на дом социального обслуживания (в том числе детский), специальный дом-интернат и иные организации (п. 29); вид «психоневрологический интернат» в перечне отсутствует.

Приложение № 2 к Правилам — рекомендуемый перечень оборудования стационарных организаций — содержит отдельную позицию «помещение для приготовления пищи получателями социальных услуг» с обеденным столом и стульями по числу одновременно пользующихся, бытовым холодильником, кухонным гарнитуром, бытовой техникой (варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, мультиварка, микроволновая печь, блендер и др.), кухонной и столовой посудой, специальной посудой, адаптированной под потребности инвалидов, аксессуарами для сервировки стола и фартуками [21] — **рекомендация**. Это первое найденное в федеральном акте признание того, что житель стационара может сам готовить еду; для шкалы раздачи (п. 1.4) оно означает, что модель М5 — жители готовят сами — имеет опору в федеральном перечне оборудования, хотя и рекомендательную. Позиция не уточняет, предназначено ли помещение для повседневного питания или для обучения бытовым навыкам; в последнем случае она относится к подготовке к сопровождаемому проживанию, а не к организации основного питания.

Последствия для вариативного меню (толкование). Во-первых, обязанность обеспечить условия для соблюдения поста превращает постное блюдо в пост из пожелания в предмет проверки регионального государственного контроля по ст. 33 442-ФЗ во всех стационарных организациях: учреждение должно уметь показать, как житель, соблюдающий пост, получает питание в пределах норм. Самый простой способ — постный вариант в составе вариативного меню; альтернативы — индивидуальная замена по заявлению или отдельный постный рацион. Юрист проекта «Регион заботы» А. Гаганов в комментарии к приказу сделал тот же вывод: норма «склоняет интернаты к необходимости обеспечивать вариативное питание хотя бы во время ре-

лигиозных постов» [31]. Во-вторых, Правила не обязывают предоставлять выбор блюд как таковой; ссылка на приказ № 305н в обоснование ежедневного выбора двух вторых блюд была бы расширительным толкованием. В-третьих, предпочтения получателя упоминаются в Правилах применительно к размещению по спальням, но не к питанию — та же асимметрия, что в критериях качества приказа № 935н (п. 1.5).

2.5 Нормы питания: приказ № 520н и методические рекомендации 2002 г.

2.5.1 Приказ № 520н

Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» признал утратившим силу приказ от 13.08.2014 № 552н и, согласно письму Минюста России от 18.10.2022 № 01/119931-АБ, не нуждается в государственной регистрации [26]. Он содержит две таблицы: для получателей 18 лет и старше и для детей от одного года до 18 лет в пяти возрастных группах. Нормы выражены в граммах (миллилитрах) брутто и нетто на человека в сутки.

Это **рекомендация** федерального уровня: субъект, утверждая свои нормы, вправе от неё отступить. В первой редакции обзора приказ № 520н отсутствует; федеральной опорой норм там названо постановление № 12 от 2002 г. [1]. Для анализа это существенно: с 2022 г. федеральный ориентир по продуктовому набору для взрослых — № 520н, а не таблицы 2002 г.

Два свойства приказа № 520н важны для выбора блюд.

Во-первых, смесь белковая композитная сухая (27 г) и витаминно-минеральные комплексы (50–100 % физиологической нормы) отмечены в нём сноской «по медицинским показаниям» [26]. Федеральная рекомендация, таким образом, не включает специализированные продукты в общий рацион каждого жителя, а связывает их с назначением. Петербургская норма, как будет показано в п. 3.2, поступает иначе.

Во-вторых, приказ задаёт продукты группами («крупы (рисовая, гречневая, пшённая, манная, овсяная и другие); горох, фасоль, чечевица» — 80 г; «овощи свежие (свёкла, морковь, капуста, лук репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зелёная стручковая)» — 340 г нетто) [26]. Внутри группы выбор конкретного продукта нормой не регламентирован. Это и есть главный источник законного пространства для вариантов: две каши из одной группы круп не требуют пересчёта нормы (толкование).

2.5.2 Постановление № 12 от 2002 г.

Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 04.06.2007 № 397) по данным справочных систем не отменено [25]. Оно содержит рекомендуемые продуктовые наборы, подробные меню-раскладки для учреждений, кроме ПНИ (приложение № 4), и для ПНИ (приложение

№ 6), а также «Нормы взаимозаменяемости некоторых продуктов при изготовлении блюд» — извлечение из приказа Минторга СССР от 12.12.1980 № 310 (приложение № 7) [25]. Первая редакция обзора называла нормы взаимозаменяемости приложением № 6 [1]; по действующей редакции в системе «Гарант» это приложение № 7. В действующей редакции есть и второй инструмент замены — приложение № 8 «Замена продуктов по белку и углеводам» (в первоначальной редакции — таблица замены продуктов по основным пищевым веществам из приказа Минздрава СССР от 12.06.1984 № 666) [25]. Для вариативного меню приложение № 8 полезнее приложения № 7: нормы Минторга описывают замену сырья при изготовлении одного и того же блюда, а таблица по белку и углеводам позволяет сопоставить разные блюда.

Пункт 3 рекомендаций формулирует требования, которые прямо касаются выбора: ежедневное включение в меню мяса или рыбы, зерновых, хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, молочных продуктов и сахара, а остальных продуктов — еженедельно по семидневному меню; коррекция рациона включением 10–20 % легкоусвояемого белка специализированных продуктов (СБКС); недопущение длительных перерывов между приёмами пищи, «особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего дня» [25]. Первое из этих требований задаёт рамку выбора: житель может выбрать между мясным и рыбным блюдом, но день без обоих рекомендаций не предусматривают. Пункт 4 рекомендует учреждениям использовать приложения № 1–9 «для самостоятельного составления меню» [25] — то есть меню составляет учреждение, а не вышестоящий орган. Отдельно Минтруд России утвердил методические рекомендации по организации диетического (лечебного) питания в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (постановление от 25.12.2003 № 90) [32]; их содержание для доклада не анализировалось.

По вторичному источнику, рекомендации 2002 г. (в части, не опубликованной в открытой версии справочной системы) допускают при наличии медицинских показаний назначение дополнительного питания с увеличением калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на 10–15 %, а также установление индивидуального объёма выдаваемой пищи [33]. Если это положение подтвердится по первоисточнику, оно — единственное найденное федеральное упоминание индивидуального объёма порции в социальном обслуживании (текст рекомендаций целиком в ходе подготовки доклада не получен; положение приведено по цитате в научной статье).

Соотношение двух федеральных документов формально не урегулировано: № 520н не отменяет № 12, и оба носят рекомендательный характер. Разумно читать их так (толкование): продуктовый набор — по № 520н как более позднему и специальному; организационные приёмы, меню-раскладки и нормы взаимозаменяемости — по № 12, пока не принято иное. В академическом слое материалов семинара упоминается приказ «№ 774н» как акт о нормах питания [17]; по открытым источникам этот номер не подтверждён.

2.5.3 Нормы физиологических потребностей

Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» служат ориентиром для расчёта пищевой ценности рациона [34]. Они не устанавливают продуктовых наборов и не регулируют порядок подачи — **рекомендация**.

2.6 Таблица замен: где она находится в праве

Практически во всех отраслевых материалах, включая обе предыдущие работы семинара, утверждается, что таблицы замен «легализуют» вариативность: если вариант Б эквивалентен варианту А по таблице, норма соблюдена [1, 16]. Проверка источников показывает, что это утверждение верно по смыслу, но требует уточнения адреса.

СанПиН. Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учётом пищевой ценности — приложение № 11 к СанПиН 4282-26 (как и ранее приложение № 11 к СанПиН 3590-20). Отсылка к ней содержится в подп. 4 п. 59 СанПиН 4282-26 («Допускается замена одного вида пищевой продукции... в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учётом её пищевой ценности (приложение № 11)») [3]; в СанПиН 3590-20 аналогичная норма — п. 8.1.4 [2]. Оба пункта расположены в разделе VIII «Особенности организации общественного питания детей». Раздел VII об особых требованиях к питанию взрослого населения, включая организации социального обслуживания (п. 56), на таблицу замен не ссылается [3]. Буквально таблица замен СанПиН является нормой для детских организованных коллективов, а для взрослых — допустимым ориентиром, применяемым по аналогии (толкование). Свердловская область сделала эту аналогию нормой регионального уровня, указав в своём акте о нормах питания замену по приложению № 11 [1, 35].

Методические рекомендации 2002 г. Нормы взаимозаменяемости приложения № 7 к постановлению № 12 — единственный найденный федеральный документ о замене продуктов, адресованный именно учреждениям социального обслуживания взрослых [25]. Его содержание восходит к приказу Минторга СССР 1980 г. — **рекомендация**.

Региональные акты. Омский приказ № 171-п отсылает к нормам взаимозаменяемости рекомендаций 2002 г.; московский приказ № 228, по описанию первой редакции обзора, предусматривает замену «по нормам взаимозаменяемости» [1]. Постановление Санкт-Петербурга № 1284 в действующей редакции положений о замене продуктов не содержит (проверено по тексту редакции от 27.06.2022 [27]).

Медицинское право. Подп. 2 п. 56 СанПиН 4282-26 требует «в дни замены пищевой продукции и блюд» подсчитывать химический состав и пищевую ценность диет, но этот подпункт адресован медицинским организациям [3].

Вывод (толкование): механизм эквивалентной замены для взрослых в социальном обслуживании существует, но держится на документах рекомендательного характера, на аналогии с детским разделом санитарных правил и на региональных актах

там, где они это предусмотрели. Для директора отсюда следует практическое требование: таблица замен, которой пользуется учреждение, должна быть утверждена его локальным актом со ссылкой на источник — приложение № 7 к рекомендациям 2002 г., приложение № 11 к СанПиН 4282-26 или региональный акт. Сама по себе ссылка «по СанПиН» для взрослого учреждения уязвима.

2.7 Санитарные правила: переход от СанПиН 3590-20 к СанПиН 4282-26

2.7.1 Хронология и действие во времени

СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18, зарегистрирован Минюстом России 02.06.2026 (№ 86854), вступил в силу 01.09.2026 и действует до 01.09.2032 [3]. Тем же постановлением признаны утратившими силу постановление от 27.10.2020 № 32 об утверждении СанПиН 3590-20 и постановление от 22.08.2024 № 9 о внесении в него изменений. Переходного периода постановление не предусматривает.

Отсюда два правила применения (толкование, основанное на общем принципе действия акта во времени). Журналы, технологическая документация и программа производственного контроля, оформленные до 31.08.2026 по формам СанПиН 3590-20, законны в том виде, в каком они составлены; переоформлять их задним числом не требуется и вредно. С 01.09.2026 действуют формы и требования СанПиН 4282-26; документы, ссылающиеся на пункты утратившего силу акта, должны быть перепривязаны. Первая редакция обзора, подготовленная до опубликования нового СанПиН, указывала, что СанПиН 3590-20 действует до 01.01.2027 [1]; эта дата утратила значение.

2.7.2 Что изменилось для организаций социального обслуживания

Предмет	СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026)	СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026)
Кратность и диетическое питание	Не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям (раздел VII, п. 7.1.11 по нумерации, приводимой в [1, 17])	То же: подп. 11 п. 56 [3]
Привлечение стороннего организатора питания	Требования к суточным пробам и помещению (п. 7.1.12–7.1.14 по [17])	При использовании готовых блюд выделяется помещение для приёма и отбора суточных проб; пробы отбирает ответственный работник пищеблока по подп. 4 (подп. 12 п. 56)
Бракераж	—	Блюдо при нарушении технологии или неготовности не выдётся до устранения; результат — в журнале бракеража по приложениям № 4 и 5 (подп. 13 п. 56)

Предмет	СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026)	СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026)
Распространение на сторонние предприятия	—	Требования п. 56 распространяются на привлекаемые предприятия общественного питания (подп. 14 п. 56)
Рекомендательные нормы	—	Оценка соблюдения рекомендательных норм не может быть предметом федерального санитарного надзора (п. 3)
Технологические документы	Требование существовало	Изготовление — по технологическим документам, утверждённым руководителем; наименования блюд в меню должны соответствовать технологическим документам (п. 11)
Время на раздаче	—	Не более 3 часов с момента изготовления для блюд, требующих разогревания; запрет реализации готовых блюд на следующий день и замораживания нереализованных блюд (п. 32)

Левый столбец заполнен по нумерации, приводимой в материалах семинара, и не сверялся с текстом СанПиН 3590-20 по каждой строке; правый — по тексту СанПиН 4282-26 [3]. Прочерк в левом столбце означает, что сопоставимое требование в материалах семинара не приводилось, а не то, что его не было.

2.7.3 Что новый СанПиН говорит о выборе

Ни СанПиН 3590-20, ни СанПиН 4282-26 не ограничивают число вариантов блюда и не обязывают предоставлять выбор [2, 3] — **толкование**, основанное на отсутствии соответствующих норм в обоих текстах. Для вариативного меню существенны четыре положения нового СанПиН.

- 1. Технологическая карта на каждый вариант** (п. 11). Каждое блюдо, указанное в меню, должно иметь технологический документ, утверждённый руководителем, с тем же наименованием. Второй вариант без ТТК — нарушение независимо от того, хорош ли он.
- 2. Три часа на раздаче** (п. 32). Ограничение касается блюд, требующих разогревания перед употреблением, и считается с момента изготовления. Для варианта, который готовится «с запасом» и ждёт спроса, это прямой предел. Остатки нельзя реализовать на следующий день и нельзя заморозить для последующей реализации.
- 3. Бракераж каждого блюда** (подп. 13 п. 56). Поскольку бракераж проводится по блюду, второй вариант требует собственной записи в журнале.
- 4. Суточные пробы** (подп. 4 и 12 п. 56). Подп. 4 сформулирован для пищеблоков медицинских организаций; к организациям социального обслуживания отсылка сделана в подп. 12 — для случая готовых блюд от стороннего предприятия. Обязанность учреждения с собственным пищеблоком отбирать суточную пробу каждого блюда прямо в п. 56 не сформулирована; на практике её следу-

ет сохранять, поскольку суточная проба от каждой партии — общая практика производственного контроля по принципам ХАССП (п. 4) и требование, которое проверяющий будет ожидать (толкование; вопрос стоит уточнить у территориального органа Роспотребнадзора).

Отдельно о п. 3. Санитарный надзор не оценивает соблюдение рекомендательных норм [3]. Продуктовые наборы приказа № 520н и рекомендаций 2002 г. рекомендательны; региональные нормы — нет, но их соблюдение контролирует не Роспотребнадзор, а орган социальной защиты (толкование). Вопрос «почему сегодня два вторых» поэтому не относится к предмету санитарного надзора; вопросы «где ТТК на второе Б», «где проба» и «сколько часов оно стоит на линии» — относятся.

2.7.4 Подп. 5 п. 56: кто раздаёт пищу

Подп. 5 п. 56 СанПиН 4282-26 требует, чтобы раздачу пищевой продукции пациентам медицинских организаций производили назначенные ответственные лица; иной персонал к раздаче не допускается [3]. Для организаций социального обслуживания прямого аналога нет; общий запрет п. 32 касается привлечения к приготовлению, порционированию и раздаче «посторонних лиц, включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности» [3]. Если вариативное меню организуется с раздачей в отделениях силами младшего медицинского персонала или помощников по уходу, раздача должна быть включена в их должностные инструкции (толкование; практическое следствие разобрано в п. 7.5).

2.8 Лечебное питание: граница компетенций

СанПиН требует организовать в стационарной организации социального обслуживания «диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям» [3]. Как именно, санитарные правила не говорят. Номенклатура стандартных диет и порядок лечебного питания установлены актами Минздрава России для медицинских организаций: приказ от 05.08.2003 № 330 (с изменениями, последнее — приказ от 19.02.2024 № 70н), приказ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», приказ от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» [3, сноски 13 и 23; 36–38].

Применимость этих актов к организациям социального обслуживания прямо не установлена. Учреждение с медицинской лицензией и врачом в штате фактически применяет их по аналогии; учреждение без врача — нет. Первая редакция обзора назвала это «недостаточной связностью социального и медицинского регулирования» [1]; формулировка точна. Отсюда правило для вариативного меню (толкование): кухня не назначает и не отменяет диету, а выбор жителя с назначенной диетой осуществляется внутри диеты. Докладом не рассматривается, какие диеты и консистенции кому назначать; это зона врача.

Клинические рекомендации «Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста» (Российская ассоциация геронтологов и гериатров, 2020; опубликованы в 2021 г.) предусматривают активный скрининг недостаточности питания у пожилых [39]. Для социального учреждения это ориентир организации медицинской части, а не норма кухни.

2.9 Закон № 3185-1 и питание в ПНИ

Для ПНИ к перечисленному добавляется Закон № 3185-1 [20]:

- ст. 5 ч. 2 — лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства (общая гарантия; материалы семинара выводят из неё недопустимость лишения еды как меры воздействия [17] — **толкование**);
- ст. 37 ч. 2 в силу ст. 43 — право исполнять религиозные обряды и соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, если это не нарушает внутренний распорядок — **норма**;
- ст. 37 ч. 3 — временные ограничения прав, в том числе на получение посылок и на приобретение предметов первой необходимости, допускаются решением заведующего отделением или главного врача по рекомендации лечащего врача; порядок устанавливается Правительством РФ — **норма** (применимость ч. 3 к жителям ПНИ сомнительна, поскольку ст. 43 отсылает только к ч. 2 и 4 ст. 37; это **толкование**).

Последний пункт важен для продуктовых передач. Перечни продуктов, «запрещённых к передаче» в ПНИ, которые публикуют учреждения [40], — локальные формы. Их законность зависит от того, обоснованы ли запреты санитарными или медицинскими причинами; ст. 43 Закона № 3185-1 не распространяет на жителей ПНИ ограничения ч. 3 ст. 37 (толкование).

Для соблюдения поста следствие прямое: вариант постного блюда в пост — не «вариативность по желанию кухни», а условие реализации права, закреплённого законом. Если житель имеет медицинские назначения, соблюдение поста согласуется с врачом; отказ от поста — такое же право в любой день.

2.10 Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Организация питания зависит от закупки сильнее, чем от рецептуры: в спецификации определяется, будет ли на складе второй продукт группы. Государственное бюджетное учреждение закупает по 44-ФЗ [41]. Автономное учреждение относится к заказчикам по 223-ФЗ (п. 1 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ) и закупает по своему положению о закупке; при неразмещении положения применяется 44-ФЗ [42]. Положения 44-ФЗ распространяются на закупки автономного учреждения за счёт субсидий на капитальные вложения (ч. 4 ст. 15 44-ФЗ) [41]. Применимость 44-ФЗ к закупкам автономного учреждения за счёт субсидии на выполнение государственного задания — предмет многолетнего спора; Минфин России разъяснял порядок использования автономными

учреждениями бюджетных средств в письме от 29.12.2014 № 02-02-08/68298 [43]. В отраслевой печати 2026 г. распространяется сообщение о том, что определением Верховного Суда РФ от 28.01.2026 № 303-ЭС25-15393 (дело № А73-20917/2024) отказано в передаче жалобы автономного учреждения, закупавшего по 223-ФЗ за счёт субсидии на госзадание, и что суды признали обязательным применение 44-ФЗ [44]. Текст определения по первоисточнику не проверен; вывод требует правовой экспертизы учредителя и в докладе не используется как установленный.

В Санкт-Петербурге оба контура представлены в одной отрасли: ДСО «Серафимовский» (автономное учреждение) закупает по 223-ФЗ, ДСО «Тесовый берег» (бюджетное учреждение) — по 44-ФЗ; пример последнего — извещение № 0372200070825000244 от 24.11.2025 об открытом конкурсе на поставку продуктов питания [45]. Сравнение закупочных решений для вариативного меню — в п. 7.7.

2.11 Ответственность

Санитарная. Общий состав — ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия); специальный — ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) [46]. Первая редакция обзора называет ст. 6.3 [1], доклад «Не просто накормить» — ст. 6.6 [16]. Это не противоречие, а соотношение общей и специальной нормы: для нарушений при организации питания применяется ст. 6.6. Прокуратура применяла её к учреждениям социального обслуживания, в том числе к социально-реабилитационному центру в Кашине [47]. Верховный Суд РФ в постановлении от 21.02.2019 № 11-АД19-4 переквалифицировал нарушение с ст. 6.6 на ст. 6.7 КоАП применительно к организации, где специальной была норма об условиях воспитания и обучения [48]; это напоминание о том, что выбор состава зависит от вида организации.

Антимонопольная. Сырьё для социальных учреждений — сфера с публичными картельными делами: ФАС России в 2024 г. сообщила о картеле на 543 торгах поставки социально значимых продуктов на сумму 4,7 млрд руб. [49]; УФАС по Челябинской области в 2025 г. — о картеле на 27 тендерах школьного питания со штрафом 5,1 млн руб. [50]. Для вариативного меню вывод узкий: избыточно детализированная спецификация, написанная «под второе блюдо», сама может ограничить конкуренцию; спецификация строится по группам продуктов, а не по поставщику (толкование).

2.12 Итог по федеральному уровню

Утверждение	Класс	Основание
Питание в стационаре — не менее 3 раз в день, включая диетическое по медицинским показаниям	Норма	Подп. 11 п. 56 СанПиН 4282-26 [3]
Нормы питания утверждает субъект	Норма	Ст. 8 442-ФЗ [18]
Федеральные продуктовые наборы	Рекомендация	Приказ № 520н [26]; рекомендации 2002 г. [25]

Утверждение	Класс	Основание
Число вариантов блюда не ограничено	Толкование	Отсутствие норм в СанПиН 3590-20 и 4282-26 [2, 3]
Обязанность предоставлять выбор блюда	Отсутствует	Ни в одном проанализированном федеральном акте
Таблица замен СанПиН	Норма для детских организаций; для взрослых — ориентир по аналогии	Подп. 4 п. 59, прил. 11 СанПиН 4282-26 [3]
Нормы взаимозаменяемости для социального обслуживания взрослых	Рекомендация	Прил. 7 к постановлению № 12 [25]
ТТК на каждый вариант с тем же наименованием	Норма	П. 11 СанПиН 4282-26 [3]
Не более 3 ч на раздаче для блюд, требующих разогрева	Норма	П. 32 СанПиН 4282-26 [3]
Право жителя ПНИ соблюдать пост	Норма	Ст. 37 ч. 2, ст. 43 Закона № 3185-1 [20]
Ограничение платы 75 % среднедушевого дохода	Норма	Ч. 4 ст. 32 442-ФЗ [18]; п. 35 приказа № 935н [19]

3 Региональные нормы питания

3.1 Архитектура регионального регулирования

После 1 января 2015 г. каждый субъект Российской Федерации утвердил собственные акты в сфере социального обслуживания. Первая редакция обзора описала их типовую структуру как четырёхуровневую: закон субъекта о социальном обслуживании; перечень социальных услуг; нормы питания (суточные продуктовые наборы в граммах брутто и нетто); порядки, стандарты и тарифы [1]. Нормы питания — центральный для темы уровень: именно они определяют, из чего кухня может приготовить два варианта.

Ни один из проанализированных региональных актов не закрепляет права проживающего на выбор блюда и не устанавливает число вариантов [1] (вывод первой редакции подтверждается для акта Санкт-Петербурга, перепроверенного по тексту; для остальных субъектов принят по первой редакции). Отсюда следует, что вариативное меню в России — повсеместно организационная инициатива учреждения, допускаемая нормами, но не предписанная ими (толкование).

Первая редакция обзора предложила классификацию норм по степени дифференциации: «многовариантная» (наборы различаются по типу учреждения и по состоянию здоровья, пример — Санкт-Петербург), «типовая» (только по типу учреждения, пример — Псковская область) и «укрупнённая» (единый набор с оговорками о замене по медицинским показаниям) [1]. Классификация полезна, но вывод, который из неё делался, — «чем богаче нормативный ассортимент, тем шире легальное пространство выбора» — нуждается в уточнении. Дифференциация по диагнозам расширяет пространство персонализации, а не выбора: житель с диабетом получает другой набор, но не получает права выбирать между наборами. Пространство выбора создаёт другое свойство нормы — формулировка позиций группами продуктов, а не конкретными продуктами (толкование, см. п. 2.5).

3.2 Санкт-Петербург: постановление № 1284

3.2.1 Реквизиты и структура

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» вступило в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015; изменено постановлениями от 27.07.2017 № 616, от 19.12.2019 № 929 и от 27.06.2022 № 561 [27, 51]. Постановлением № 929 приложение изложено в новой редакции с 01.01.2020 [51]; постановлением № 561 изменены, в частности, нормы по крупам и мясу (отметки «в ред. Постановления... от 27.06.2022 N 561» у соответствующих строк) [27].

Приложение состоит из нескольких самостоятельных норм [27]:

1. нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме — в четырёх столбцах: учреждения, кроме ПНИ; ПНИ; лица с сахарным диабетом; лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
2. нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов в ПНИ **без смеси белковой композитной сухой** — отдельная таблица;
3. нормы питания беременных женщин и кормящих матерей;
4. нормы питания детей первого года жизни, проживающих с матерями;
5. нормы питания детей от 1 года до 18 лет;
6. нормы специализированного лечебного энтерального питания для получателей от 4 лет, в том числе на длительном зондовом питании, с индивидуальным расчётом по формуле действительного расхода энергии.

Для полустационарной формы установлена структура рациона в процентах от стационарной нормы: завтрак — 30 %, обед — 40 %, полдник — 10 %, ужин — 20 % [27].

3.2.2 Две нормы для ПНИ

Первая редакция обзора привела нормы для ПНИ по столбцу таблицы 1 и указала, что ПНИ-норма Санкт-Петербурга включает 27 г СБКС [1]. Это верно, но неполно: в постановлении есть вторая, самостоятельная норма для ПНИ — без СБКС (таблица 2). Сравнение двух ПНИ-норм показывает, чем региональный нормотворец «заменил» 27 г белковой смеси [27]:

Продукт (нетто, г/сут)	ПНИ, табл. 1 (с СБКС 27 г)	ПНИ, табл. 2 (без СБКС)	Разница
Хлеб ржаной	150	200	+50
Хлеб пшеничный	200	250	+50
Крупы, бобовые	49,6	70	+20,4
Мясо (говядина, свинина)	70,5	85,2	+14,7
Птица потрошёная	36,5	35	-1,5
Масло сливочное	20	23	+3
Масло растительное	20	23	+3
Маргарин	10	4	-6
Овощи, картофель, фрукты, молоко, творог, рыба	без изменений	без изменений	0

Постановление не указывает, в каких случаях применяется каждая из двух норм (проверено по тексту [27]). Наиболее естественное прочтение (толкование): учреждение вправе обеспечивать жителей ПНИ либо по норме с СБКС, либо по норме без неё, компенсируя белковую смесь хлебом, крупами и мясом. Для вариативного

меню это прецедент, который стоит видеть: региональный акт сам содержит пару эквивалентных наборов. Выбор между ними делает учреждение, а не житель, но логика «два пути к одной пищевой ценности» заложена в норму.

3.2.3 Петербургская норма и федеральная рекомендация

Сопоставление общей нормы Санкт-Петербурга (столбец «учреждения, кроме ПНИ») с рекомендуемыми нормами приказа № 520н показывает, что петербургская норма не является производной от федеральной: она старше (принята в 2014 г., последняя редакция — от 27.06.2022; приказ № 520н издан 13.09.2022) и устроена иначе [26, 27].

Продукт (нетто, г/сут на человека)	Приказ № 520н, 18+ [26]	СПб № 1284, кроме ПНИ [27]	СПб № 1284, ПНИ (табл. 1) [27]
Хлеб ржаной	150	150	150
Хлеб пшеничный	150	100	200
Мука пшеничная	15	45	45
Макаронные изделия	20	20	25
Крупы, бобовые	80	80	49,6
Картофель	200	168	268
Овощи (все группы, включая зелень, солёные и консервированные)	394,5 ¹	318	380
Фрукты свежие	150	200	100
Соки	100 мл	60	60
Мясо	90	90	70,5
Птица	22,2	40	36,5
Колбаса, сосиски	12	25	25
Рыба, рыбопродукты	32,5	41,8	46,7
Творог	20	40	50
Сыр	15	14	9,3
Яйцо	½ шт./сут (3,5 шт./нед)	4 шт./нед	4 шт./нед
Молоко	200 мл	200	200
Кисломолочные продукты	121 мл	200	200
Масло сливочное	20	20	20
Масло растительное	20 мл	20	20
Сметана	15	10	15
Сахар и кондитерские изделия	50 (вместе)	57 + 15 = 72	57 + 15 = 72
Соль	8	10	10
СБКС	27 — по медицинским показаниям	27 — в общей норме	27 — в общей норме

Продукт (нетто, г/сут на человека)	Приказ № 520н, 18+ [26]	СПб № 1284, кроме ПНИ [27]	СПб № 1284, ПНИ (табл. 1) [27]
Витаминно-минеральные комплексы	50–100 % физиол. нормы — по медицинским показаниям	1 драже 3 раза в неделю	1 драже 3 раза в неделю

¹ Сумма строк приказа № 520н: овощи свежие 340 + солёные и маринованные 15 + зелень 14,8 + консервированные 24,7 (иллюстративная арифметика автора; в приказе группы приведены раздельно).

Из сопоставления следуют три наблюдения.

Первое. По ряду позиций петербургская норма щедрее федеральной рекомендации: птица (40 против 22,2 г), творог (40 против 20 г), кисломолочные продукты (200 против 121), рыба (41,8 против 32,5), фрукты (200 против 150). По другим — скромнее: картофель (168 против 200), овощи (318 против 394,5), соки (60 против 100). Выбор блюд, построенный на петербургской норме, имеет запас именно в белковых позициях, что облегчает пары «мясо — птица — рыба» (толкование) [26, 27].

Второе. Специализированные продукты (СБКС и витаминно-минеральные комплексы) в Санкт-Петербурге входят в общую норму каждого проживающего, а в федеральной рекомендации — только по медицинским показаниям [26, 27]. Это решение регионального нормотворца, а не противоречие: регион вправе установить более широкий набор. Однако оно порождает практический вопрос, который должен решаться врачом, а не кухней: включать ли смесь в блюда всем или выдавать по назначению.

Третье. Пункты, сформулированные группами («крупы, бобовые» 80 г; «овощи свежие, овощи солёные и маринованные, овощи консервированные, зелень» 318 г; «говядина, свинина» 90 г), оставляют внутри группы свободу выбора конкретного продукта. Две каши из одной группы, два салата из одной группы овощей, котлета из говядины и тефтели из свинины — варианты, не требующие пересчёта нормы. Пары между группами (мясо — рыба, картофель — крупа) требуют таблицы замен, которой в постановлении № 1284 нет (п. 2.6) [27].

3.2.4 Порядок и тарифы

Нормы питания петербургских учреждений действуют в связке с двумя другими актами. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 утверждены порядки предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, в том числе в стационарной форме [52]. Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждает Комитет по социальной политике: на 2025 г. — распоряжением от 13.12.2024 № 1366-р, на 2026 г. — распоряжением от 15.12.2025 № 1155-р [53].

Тарифы 2025 г. на услугу «обеспечение питанием согласно утверждённым нормативам» в стационарной форме устроены зеркально нормам постановления № 1284 — по тем же категориям [53]:

Категория (стационарная форма)	Тариф 2025 г., руб. в день
Граждане пожилого возраста и инвалиды, кроме ПНИ	560,87
То же, с сахарным диабетом	549,77
То же, с заболеваниями ЖКТ	423,36
ПНИ	571,63
ПНИ, с сахарным диабетом	549,77
ПНИ, без смеси белковой композитной сухой	480,86
ПНИ, с заболеваниями ЖКТ	423,36

Две особенности таблицы существенны для вариативного меню. Первая: разница между двумя ПНИ-нормами (с СБКС и без неё) составляет 90,77 руб. в день — это цена, которую тарифный орган присвоил решению «27 г белковой смеси или компенсация хлебом, крупами и мясом» (иллюстративная арифметика: 571,63 – 480,86). Вторая: тариф рассчитан на норму, а не на меню; он не содержит составляющей на организацию выбора. Тарифы 2026 г. в ходе подготовки доклада не анализировались (опубликованный текст распоряжения № 1155-р доступен в виде графического образа) [53].

3.2.5 Что первая редакция сообщала о петербургской практике

Первая редакция обзора называла практику петербургских учреждений «циклическими меню с альтернативными позициями» и ссылалась на пилотный проект «Система свободного выбора „Вариативное меню“» по данным доклада Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 г. [1, 54]. Проект, о котором идёт речь в этом докладе, относится к образовательным организациям, то есть к школьному питанию, и к организациям социального обслуживания взрослых отношения не имеет. Сведения о вариативном меню в ДСО «Серафимовский», опубликованные Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 22.07.2025 [15], в первой редакции не использованы.

3.3 Москва

Нормы питания получателей социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания Москвы утверждены приказом Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от 22.03.2021 № 228, вступившим в силу с 01.04.2021 [55]. По описанию первой редакции обзора, наборы дифференцированы по видам организаций, предусматривают диетическое питание по медицинским показаниям, замену продуктов «по нормам взаимозаменяемости» и отсылку к Сан-Пин 3590-20 [1]. Текст приказа в ходе подготовки второй редакции повторно не сверялся.

Первая редакция также описывала московскую практику как «циклическое меню с элементами выбора», дегустации и опросы удовлетворённости в пансионатах [1]. Эта характеристика в обзоре не подкреплена источником; во второй редакции она не воспроизводится как факт. Публичного описания вариативного меню в конкретном московском учреждении с реквизитами в ходе подготовки доклада не найдено.

3.4 Свердловская область

Нормы питания утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП, заменившим постановление № 1037-ПП [35]. По данным первой редакции обзора, акт включает СБКС (27 г) и витаминно-минеральные комплексы в суточный набор и устанавливает замену продуктов по таблице приложения № 11 к СанПиН 3590-20 со ссылками на весь действовавший массив санитарных правил [1]. Если это изложение точно, свердловский акт — единственный из проанализированных, где применение детской таблицы замен к взрослым возведено в региональную норму. После 01.09.2026 ссылки акта на СанПиН 3590-20 требуют актуализации на СанПиН 4282-26 (таблица замен в новом СанПиН сохранила номер приложения — 11) [3].

3.5 Нижегородская область

Нормы питания утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709; ведомственным актом в сфере социального обслуживания назван приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214 [56]. По описанию первой редакции, наборы дифференцированы по видам учреждений; диетическое питание — по медицинским показаниям с заменой по нормам взаимозаменяемости [1]. Утверждение первой редакции о том, что «на уровне учреждений... элементы выбора блюд внедряются по инициативе учреждений», источником не подкреплено и здесь не воспроизводится как факт.

3.6 Омская область

Нормы утверждены приказом от 11.11.2014 № 171-п [57]. По данным первой редакции, акт отсылает к нормам взаимозаменяемости методических рекомендаций 2002 г., к СанПиН 3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, а диетическое питание связывает со ст. 25.5 29-ФЗ и ст. 39 323-ФЗ [1]. Омские учреждения публикуют на сайтах сведения о питании и перечни продуктов, ограниченных к передаче [40]. Публикация меню и правил — инструмент, который вариативному меню нужен в любом регионе: житель и семья должны знать, из чего выбирают.

3.7 Псковская область

Нормы питания утверждены приказом Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206 [58]. Наборы дифференцированы по категориям учреждений (дома-интернаты, дома ветеранов, ПНИ), диетическое питание орга-

низуется со ссылкой на приказы Минздрава России № 395н и № 330 [1]. Псковский акт иллюстрирует общую закономерность: диетологическую логику региональные нормы заимствуют из здравоохранения.

3.8 Другие субъекты

В материалах семинара в числе региональных норм названы также постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458 и постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 306-п [16, 59]. Их содержание для второй редакции не анализировалось; реквизиты приводятся для полноты картины.

3.9 Республика Татарстан: пример из здравоохранения

Первая редакция обзора включила в региональный раздел аудит организации питания в республиканской клинической психиатрической больнице, проведённый контрольным органом Республики Татарстан: стоимость питания составила около 224–310 руб. на койко-день, фактические рационы были занижены против рекомендуемых норм [1, 60]. Это учреждение здравоохранения, и цифры к стоимости питания в организациях социального обслуживания напрямую не переносятся. Ценен методический вывод аудита: наличие норм не гарантирует их исполнения, и проверка должна сопоставлять нормы с фактической закладкой. Ссылка первой редакции на «акт Минтруда Республики Татарстан» о нормах питания дана без реквизитов [1] и во второй редакции не используется.

3.10 Сравнение

Субъект	Акт	Дифференциация	СБКС/ВМК в общей норме	Замена продуктов	Статус сведений
Санкт-Петербург	Пост. от 29.12.2014 № 1284 (ред. № 561 от 27.06.2022)	По типу учреждения и состоянию здоровья; две нормы для ПНИ	Да	Не предусмотрена в тексте	Проверено по тексту [27]
Москва	Приказ ДТСЗН от 22.03.2021 № 228	По видам организаций	Обогащение предусмотрено (по [1])	По нормам взаимозаменяемости (по [1])	По первой редакции
Свердловская обл.	Пост. от 10.11.2022 № 765-ПП	По видам учреждений	Да (по [1])	По прил. 11 СанПиН (по [1])	По первой редакции
Нижегородская обл.	Пост. от 20.10.2014 № 709; приказ от 21.04.2022 № 214	По видам учреждений	Нет данных	По нормам взаимозаменяемости (по [1])	По первой редакции
Омская обл.	Приказ от 11.11.2014 № 171-п	По видам учреждений	Нет данных	По рекомендациям 2002 г. (по [1])	По первой редакции

Субъект	Акт	Дифференциация	СБКС/ВМК в общей норме	Замена продуктов	Статус сведений
Псковская обл.	Приказ КСЗН от 14.07.2020 № 206	По видам учреждений	Нет данных	Нет данных	По первой редакции
Красноярский край	Пост. от 17.12.2014 № 607-п	Не анализировалось	—	—	Реквизиты [59]

3.11 Что региональные нормы дают выбору

Региональная норма отвечает на вопрос «сколько», а не «что и как». Она определяет суточное количество продуктов по группам и почти никогда не определяет набор блюд, число вариантов, время и место подачи. Это создаёт широкое пространство организационной свободы, которое на практике заполняется привычкой: одно меню на всех, потому что так проще считать раскладку (толкование).

Для учреждения, вводящего выбор, из региональной нормы следуют три практических требования. Суммарная закладка продуктов за отчётный период (неделя, декада, месяц) должна соответствовать норме по каждой группе. Варианты, построенные внутри группы продуктов, норму не затрагивают. Варианты между группами требуют утверждённой учреждением таблицы замен со ссылкой на источник. Средний по периоду, а не ежедневный расчёт — допустимый способ контроля; его законность для взрослых учреждений прямо не установлена (в СанПиН он закреплён для детей — подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26 допускает отклонение по приёмам пищи $\pm 5\%$ при соблюдении среднего за неделю [3]), поэтому способ контроля также следует закрепить локальным актом (рекомендация).

4 Российские практики: что известно из открытых источников

4.1 Метод и ограничения

В этом разделе собраны публичные сообщения о вариативном питании в российских стационарных организациях социального обслуживания, найденные к 05.10.2026. Каждое сообщение разобрано в два слоя: что источник сообщает и чего он не сообщает. Новость учреждения или органа власти — это факт сообщения на дату публикации, а не результат проверки. Ни один из перечисленных ниже кейсов не сопровождается опубликованными данными о весе, потреблении, отходах или затратах; поэтому кейсы иллюстрируют организационные решения, но не доказывают эффекта.

По сравнению с первой редакцией, где был описан один российский кейс (Болотнинский ПНИ) [1], здесь рассмотрены восемь учреждений и одно региональное сообщение. Часть сведений получена при повторной проверке сайтов учреждений в октябре 2026 г. и уточняет как первую редакцию, так и рабочую базу знаний проекта [17].

Классификация по шкале раздачи (M0–M5, п. 1.4) дана автором по тексту сообщений и является толкованием.

4.2 Болотнинский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» от 16.08.2024: с 2024 г. «несколько раз в неделю введено вариативное питание»; в такие дни в меню на завтрак и обед включены несколько вариантов блюд; на завтрак — чай, какао или кофейный напиток, молочная каша либо суп; в обед — «разнообразие салатов и вторых блюд, а также десерт, фрукты и творог»; перечень блюд определяет медицинская сестра диетическая; учреждение планирует расширить вечернее меню [5]. Повторная публикация от 03.09.2026 описывает обед с выбором между курицей (жареной или отварной) с гречкой и салатами; суп указан один [6].

Чего источник не сообщает. Доли жителей, участвующих в выборе; способа выбора для неговорящих жителей; изменений в закупках и штате; данных о потреблении. Первая редакция обзора утверждала, что выбор в Болотнинском ПНИ делается накануне и «без изменения норм питания» [1]; в тексте сообщения 2024 г. ни того, ни другого нет. Эти детали во второй редакции сняты.

Модель. Выбор в момент еды из ограниченного перечня, формируемого диетсестрой, — M1 по шкале раздачи (несколько дней в неделю). Публикация 2026 г. показывает, что практика сохранилась спустя два года.

4.3 Успенский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» от 13.08.2024 (рассказ начальника отдела питания): в марте 2024 г. «все отделения перешли на вариативное меню»; жители выбирают из двух видов вторых блюд, салатов и напитков, «составляя свой обед или ужин»; например, два рыбных или два мясных блюда, салаты из свежих или отварных овощей (винегрет, салат из свёклы). Перед внедрением проведены опрос жителей и анкетирование, по результатам которого блюда «расставлены по балльной системе в зависимости от степени спроса». Сотрудники опасались, что части жителей будет трудно подойти к линии раздачи и выбрать блюдо; опасения не подтвердились. Одновременно обновлена посуда и проведены занятия по этикету за столом. Меню — перспективное семидневное летне-осеннее [7].

Публикация регионального информационного агентства от 23.10.2025 со ссылкой на министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщает, что к проекту «Шведский стол» присоединилось третье отделение интерната: жители «сами решают, что и сколько съесть»; руководство планирует распространить практику на все отделения; заместитель министра отметил улучшение аппетита [8].

Чего источники не сообщают. Сведений о количестве жителей и отделений; о затратах; о жителях, которые не могут выбрать сами. Сообщение 2024 г. не уточняет, ежедневен ли выбор (в рабочей базе знаний проекта он описан как ежедневный [17] — это прочтение, а не цитата). Утверждение заместителя министра об аппетите не подкреплено данными измерений.

Модель и противоречие слоёв. В 2024 г. — М2 (два варианта нескольких блюд на линии раздачи во всех отделениях). В 2025 г. в части отделений — формат самообслуживания со свободой порции, ближе к М3. Рабочая база проекта фиксирует Успенский ПНИ как М2 с пометкой «шведской линии в источнике нет» [17]; для сообщения 2024 г. это верно, для сообщения 2025 г. — уже нет. Слои описывают разные даты и не противоречат друг другу, если дату указывать.

4.4 Каменский психоневрологический интернат (Новосибирская область)

Что сообщает источник. Публикация ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» от 19.08.2024: «с июля месяца два раза в неделю» проживающие могут выбирать блюда из меню «исходя из собственных предпочтений и особенностей здоровья»; повара готовят несколько вариантов меню; приведён отзыв жителя о том, что у него «улучшился аппетит» [9].

Чего источник не сообщает. Какие блюда и в каком приёме пищи выбираются, сколько жителей участвует, как учитываются «особенности здоровья» и кто их оценивает.

Модель. Выбор два дня в неделю — М1 по шкале раздачи (толкование). Сообщение о лучшем аппетите — высказывание одного жителя, а не измерение. Каменский интернат — третье учреждение Новосибирской области, сообщившее о вариативном питании летом 2024 г. (вместе с Болотнинским и Успенским); совпадение сроков публикаций (13, 16 и 19 августа 2024 г.) позволяет предположить общий региональный импульс, но документа регионального органа, который бы его подтверждал, найти не удалось (открытая новостная лента министерства труда и социального развития Новосибирской области при проверке была недоступна) [5, 7, 9].

4.5 Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область)

Что сообщают источники. Учреждение (в публикациях 2024 г. — Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер», ныне ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания») опубликовало четыре сообщения [10]:

- 27.09.2024: с сентября «постепенное введение вариативного меню»; на начальном этапе — для жителей, посещающих столовую; проведён «подробный опрос», продукты и блюда сгруппированы «по уровню их популярности», чтобы избежать однообразия и сохранить сбалансированность; в первый день жители выбирали на линии раздачи салат и второе блюдо, «остальной набор меню был... как всегда, накрыт»;
- 17.12.2024: пример обеда — выбор гарнира (рис или гречка) и второго блюда (гуляш мясной или печень по-строгановски); в учреждении работает экспертная комиссия по питанию, которая вносит изменения в перспективное меню и оценивает качество методом опроса и наблюдения; с 01.01.2025 ассортимент планировалось расширить (выпечка с начинкой по выбору, пельмени или вареники, напитки);
- 13.02.2025: пищеблок ежедневно готовит на 220 человек «по восьми видам меню с правом выбора в обед»; меню цикличное 14-дневное, питание шестизачное;
- 09.02.2026: заседание совета по питанию; внештатный нутрициолог проанализировала «вариативное цикличное меню» и рекомендовала, в частности, заменить хлеб размооченными гренками для лиц с нарушенным глотанием; фельдшер предложила рассчитывать энергетическую потребность по формуле Миффлина — Сан Жеора; поставлена задача скорректировать меню для граждан 60+.

Чего источники не сообщают. Как выбирают жители, не посещающие столовую; есть ли выбор вне обеда; затраты; данные о потреблении.

Значение кейса. Это единственная из найденных российских практик, где публично описаны все четыре стадии: исследование предпочтений до запуска, поэтапный старт с наиболее мобильной группы, коллегиальный орган, который пересматривает меню, и внешняя экспертиза через полтора года. Сочетание «цикличное 14-дневное меню» и «право выбора в обед» наглядно показывает, что цикличность и вариативность — разные свойства одного меню (п. 1.2). Рекомендация нутрициолога о тек-

стуре хлеба — пример клинического вопроса, который возникает при расширении выбора и решается не кухней, а специалистом (рекомендация учреждения, не норма).

Учреждение — бывший дом-интернат для престарелых и инвалидов, а не ПНИ. Рабочая база проекта относит «четыре публичных кейса Новосибирской и Иркутской областей» к ПНИ [17]; для Усть-Илимска это неточно.

4.6 Иркутская область: региональное сообщение и Чунский ДСО

Что сообщают источники. Пересказ на агрегаторе новостей сообщения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14.02.2025: в стационарных учреждениях региона организовано вариативное питание с выбором из двух первых, двух вторых блюд и гарниров [11]. Оригинал сообщения на сайте министерства найти не удалось; агрегатор при повторной проверке в октябре 2026 г. был закрыт защитой от автоматического доступа, текст по нему не перепроверен. Сообщение пресс-службы правительства Иркутской области от 26.11.2025 о Чунском доме социального обслуживания (ранее Чунский психоневрологический интернат «Радуга», 255 мест) называет вариативное питание среди условий проживания [12].

Чего источники не сообщают. Сколько учреждений перешло на выбор; закреплено ли это региональным актом; с какой периодичностью. В открытом доступе не найден региональный правовой акт Иркутской области, который предписывал бы вариативное питание; порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме (приказ министерства от 11.12.2014 № 193-мпр) содержит лишь общую обязанность обеспечивать питание по нормам [13].

4.7 Красавинский дом социального обслуживания (Вологодская область)

Что сообщает источник. Сообщение информационного агентства от 05.07.2026: в июне 2026 г. в Вологодской области создана межрегиональная методическая площадка для внедрения вариативного меню и «шведского стола»; организатор — Красавинский дом социального обслуживания, интегрировавший вариативное меню в 2025 г.; представители Новосибирской, Тюменской областей и Удмуртской Республики рассказали об организации питания через аутсорсинг, о формате «шведского стола» и о применении инфоматов для выявления вкусовых предпочтений; мероприятие связано с национальным проектом «Семья» [14].

Чего источник не сообщает. Модели выбора, охвата, затрат. Учреждение имеет организационно-правовую форму автономного учреждения (АОУ СО ВО), что предполагает закупки по 223-ФЗ, если учреждение приняло положение о закупке (толкование; положение не анализировалось).

Значение. Появление межрегиональной площадки показывает, что к 2026 г. практика вышла за пределы единичных учреждений и стала предметом методической работы региональных ведомств. Упоминание инфоматов для сбора предпочтений — первое в найденных российских источниках указание на технический канал выбора, кроме устного [14].

4.8 ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург)

Автор доклада — директор этого учреждения; конфликт интересов раскрыт. Ниже приведены только сведения из публичных источников; внутренние данные учреждения в доклад не включены.

Что сообщают источники. Сообщение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025 о заседании рабочей группы по реформированию психоневрологических интернатов Санкт-Петербурга: руководитель ДСО «Серафимовский» представил первые результаты внедрения вариативного меню для части жителей; в течение нескольких месяцев проживающим предлагалось накануне выбрать рацион на следующий день из предложенного меню; учреждение закупило дополнительное оборудование и добавило сотрудников для организации питания; жители «с энтузиазмом восприняли» эксперимент, но полный переход «крайне затруднителен с точки зрения соблюдения всех норм питания по сбалансированности и учёта особенностей здоровья проживающих»; жители «склонны к выбору популярных, но не самых полезных продуктов» [15].

Приказом учреждения от 10.03.2026 № 124 утверждены правила внутреннего распорядка, в которых закреплено заказное питание (вариативное меню), в том числе для маломобильных жителей с приёмом пищи в жилых комнатах [22]. Сайт учреждения прекратил работу; правила доступны в веб-архиве (копия от 15.04.2026). По данным архивной копии сайта (февраль 2026 г.), учреждение обслуживало 1 004 человека, питание шестизразовое, с поздним вторым ужином [17, 22].

Чего источники не сообщают. Доли жителей, пользующихся заказом; числа добавленных ставок и стоимости оборудования; данных о потреблении и отходах.

Независимое упоминание петербургской практики есть в исследовании проекта «Если быть точным» (09.04.2026): со слов С. Мамоновой (БО «Перспективы»), «в одном из петербургских интернатов небольшой группе наиболее самостоятельных подопечных позволили самим выбирать еду из предложенных вариантов меню», при этом такие изменения «не носят массового характера» [4]. Учреждение в публикации не названо, поэтому отождествлять это свидетельство с ДСО «Серафимовский» нельзя; оно подтверждает лишь, что в 2025–2026 гг. выбор в петербургских ПНИ оставался доступен узкой группе жителей.

Модель и классы утверждений. Заказ накануне из предложенного меню — М1 по шкале раздачи: выбор есть, но сделан не в момент еды (п. 1.4). Приказ № 124 — **локальная форма**; он показывает, что учреждение может закрепить вариативное питание в правилах внутреннего распорядка, но не является нормой ни для других учреждений, ни для проверяющего.

Сообщение Комитета содержит две оценки, которые нередко цитируют порознь: жители приняли выбор с энтузиазмом, и полный переход затруднителен. Вторая оценка — суждение руководителя учреждения, а не результат измерения; данные о влиянии выбора на состав фактического потребления в сообщении не приводятся. Научные данные по этому вопросу противоречивы (п. 5.3): в исследовании Wheeler и соавт. переход к выбору в момент еды сопровождался чуть большим потреблением белковых продуктов и овощей и меньшим — углеводов в расчёте на приём пищи [61].

4.9 «Добрый дом „Солнечногорский“» (Московская область)

Что сообщает источник. Страница «Питание» сайта ГАСУСО МО «Добрый дом „Солнечногорский“» (ранее Солнечногорский ПНИ): утверждены «зимнее» и «летнее» 14-дневное меню с пяти- и шестirazовым лечебным и профилактическим питанием; меню разработано с учётом норм питания в ПНИ, утверждённых распоряжением министерства социального развития Московской области от 13.04.2017 № 19РВ-32; работает совет по питанию со ссылкой на приказ Минздрава России № 330; «по желанию получателей социальных услуг и по согласованию с лечащим врачом» совет рассматривает замену или введение новых блюд; обеденный зал рассчитан на 120 мест, маломобильные жители едят в обеденных зонах жилых корпусов; приём пищи поточный, жители могут самостоятельно обслуживаться на раздаточной линии; на сайте опубликовано «14-дневное вариативное меню» [23].

Чего источник не сообщает. Есть ли ежедневный выбор между блюдами при каждом приёме пищи; как устроен выбор в жилых корпусах.

Классификация. Механизм «замена блюда по желанию через совет с согласия врача» — это персонализация меню, а не выбор в момент еды (п. 1.2). Самообслуживание на линии само по себе не означает выбора между вариантами: линия может выдавать одно блюдо. Рабочая база проекта называет распоряжение № 19РВ-32 медицинским «мостиком» к лечебному питанию [17]; по тексту сайта это нормы питания в ПНИ Московской области, а ссылка на приказ № 330 относится к совету по питанию. Уточнение вносится во вторую редакцию.

4.10 Сводная таблица

Учреждение	Тип	Дата первого сообщения	Что выбирают	Когда выбирают	Модель (толкование)	Опубликованные измерения
Болотнинский ПНИ	ПНИ	16.08.2024	Напиток, каша/суп; салаты, вторые, десерт	В момент еды, несколько дней в неделю	М1	Нет

Учреждение	Тип	Дата первого сообщения	Что выбирают	Когда выбирают	Модель (толкование)	Опубликованные измерения
Успенский ПНИ	ПНИ	13.08.2024	Два вторых, два салата, два напитка; с 2025 г. в части отделений — самообслуживание	В момент еды	М2 → М3 (часть отделений)	Нет
Каменский ПНИ	ПНИ	19.08.2024	Несколько вариантов меню	Два дня в неделю	М1	Нет
Усть-Илимский ДСО	Бывший дом-интернат общего типа	27.09.2024	Салат и второе; гарнир	В момент еды, обед	М1 → М2	Нет (есть экспертиза меню 2026 г.)
Учреждения Иркутской обл.	Разные	14.02.2025	Два первых, два вторых, гарниры	Не указано	Не определяется	Нет
Чунский ДСО	Бывший ПНИ	26.11.2025	Не указано	Не указано	Не определяется	Нет
Красавинский ДСО	Не указано	05.07.2026	Не указано (вариативное меню, «шведский стол» на площадке)	Не указано	Не определяется	Нет
ДСО «Серафимовский»	Бывший ПНИ	22.07.2025	Рацион следующего дня из предложенного меню	Накануне	М1	Нет
«Добрый дом „Солнечногорский“»	Бывший ПНИ	Не датировано	Замена блюда по желанию через совет	По заявке	Персонализация	Нет

4.11 Что следует из совокупности кейсов

Повторяющиеся элементы в сообщениях разных учреждений таковы. Первое: изучение предпочтений до запуска (опрос и балльное ранжирование в Успенском ПНИ, опрос и группировка по популярности в Усть-Илимске). Второе: ограниченный старт — по дням недели (Болотнинский, Каменский), по группе жителей (Усть-Илимск, Серафимовский), по отделениям (Успенский в 2025 г.). Третье: выбор ограничен одним-двумя блюдами приёма пищи, остальное подаётся по общему меню. Четвёртое: коллегиальный орган — совет или комиссия по питанию — появляется в Усть-Илимске и в «Солнечногорском».

Различаются кейсы ресурсной стороной. Новосибирские и иркутские сообщения не упоминают дополнительного персонала или оборудования; петербургское сообщение их называет [15]. Первая редакция обзора утверждала, что опыт «показывает возможность введения выбора без существенного роста затрат» [1], и одновременно — в разделе о рисках — что вариативное меню «объективно дороже» [1]. Ни одно из этих утверждений не основано на опубликованных расчётах. Корректный вывод скромнее: стартовый формат (выбор из двух блюд в момент еды в одном приёме пищи) в ряде учреждений был введён без публично названных дополнительных ресурсов; заказ накануне и обслуживание маломобильных в комнатах потребовали ресурсов в учреждении, сообщившем о них (толкование).

Ни одно учреждение не опубликовало данных о весе жителей, потреблении или отходах до и после внедрения. Это главный пробел российской практики: без таких данных спор о пользе и вреде выбора остаётся спором мнений, а аргумент «популярное не самое полезное» не может быть ни подтверждён, ни опровергнут.

5 Научные данные

5.1 Зачем доклад о праве обращается к исследованиям

Спор о вариативном меню в российских учреждениях ведётся главным образом аргументами двух типов: «выбор улучшает качество жизни» и «выбор ухудшит питание, потому что жители предпочтут невкусное полезному вкусному вредному». Оба аргумента — эмпирические и поддаются проверке. Этот раздел излагает, что о них известно из рецензируемой литературы. Поиск вёлся в Europe PMC, PubMed, Кокрейновской библиотеке и eLIBRARY/КиберЛенинке по запросам о выборе блюд (menu choice, food choice, mealtime choice), автономии при приёме пищи, мальнутриции, отходах с тарелки и качестве жизни в учреждениях длительного ухода. Приводятся только работы, библиографические данные и ключевые числа которых проверены по аннотации или полному тексту.

5.2 Масштаб проблемы: недостаточность питания в учреждениях

Наиболее полная оценка распространённости недостаточности питания у пожилых по инструменту MNA (Mini Nutritional Assessment) — метаанализ Cereda и соавт. 2016 г.: 240 исследований, 113 967 человек. Распространённость составила 3,1 % у живущих дома, 17,5 % (95 % ДИ 14,3–20,6) в домах престарелых (nursing homes), 28,7 % (21,4–36,0) в учреждениях длительного ухода (long-term care) и 22,0 % в больницах [62]. Доля лиц в зоне риска в учреждениях выше доли лиц с установленной недостаточностью в несколько раз.

Российских популяционных данных по стационарным организациям социального обслуживания в рецензируемой литературе найти не удалось. Ближайшая по смыслу работа — исследование Горелика С. Г. и соавт. (2020) в учреждении для пожилых: из 97 обследованных по MNA недостаточность питания выявлена у 10,4 %, риск недостаточности — у 72,1 %, нормальный статус — у 17,5 %; у 17,9 % суточное потребление жидкости было ниже 750 мл. После коррекции рациона улучшение нутритивного статуса отмечено у 73,5 % [33]. Ограничения работы существенны: одно учреждение, средний возраст 64,7 года, отсутствие контрольной группы; поэтому цифра «улучшение у 73,5 %» не может быть приписана конкретному вмешательству. Ценность работы для нашей темы — в цифре риска: почти три четверти жителей одного российского учреждения находились в зоне риска по питанию.

Российская ассоциация геронтологов и гериатров в клинических рекомендациях 2020 г. по недостаточности питания у пожилых предусматривает скрининг по MNA и комплекс мер, включающий обогащение рациона и устранение причин сниженного потребления [39]. Рекомендации обращены к медицинским работникам; в организациях социального обслуживания они применимы в той части, в которой учреждение оказывает медицинскую помощь (толкование, см. п. 2.8).

5.3 Выбор и удовлетворённость

Самое известное исследование выбора в институциональном питании — работа Wright, Connolly, Capra и Hendrikz (2013, Brisbane). Обследованы 103 пациента больницы и 210 жителей девяти домов престарелых. Удовлетворённость питанием была связана с количеством предлагаемых вариантов и с моментом выбора: чем ближе выбор к приёму пищи и чем больше вариантов, тем выше удовлетворённость ($P < 0,01$). Авторы рекомендовали сокращать разрыв между выбором и подачей еды [63]. Это одна из немногих работ, где именно время выбора, а не только число вариантов, выделено как самостоятельный фактор, — довод в пользу различия M1 (выбор накануне) и M2 (выбор в момент еды) в шкале раздачи.

Работа Abbey, Wright и Capra (2015) описала, как выбор реально устроен в австралийских домах престарелых. Исследование включало национальный опрос учреждений о планировании меню (247 учреждений), анализ меню (161) и наблюдение 36 приёмов пищи. Уровень выбора оказался низким во всей выборке, особенно для жителей, получающих протёртую пищу; признаки того, что меню планируется с расчётом на альтернативы, были ограничены. Авторы предложили усилить регулирование и мониторинг выбора в рамках национальных стандартов аккредитации [64]. Этот вывод прямо относится к российским ПНИ и домам-интернатам: формальное наличие двух блюд на линии раздачи не означает, что выбор доступен жителю, который получает протёртую пищу или не может объяснить своё желание словами.

Wheeler, Abbey и Capra (2025) сравнили в одном австралийском учреждении две системы: традиционную (меню, выбираемое заранее) и систему, в которой житель выбирает из семи горячих блюд в момент подачи. Удовлетворённость выросла с 3,60 до 4,57 балла по пятибалльной шкале. По сравнению со стандартным блюдом приём пищи из нового меню давал чуть больше белковых продуктов (+5 г) и овощей (+11 г) и меньше углеводов (–38 г). Производственные отходы выросли с 55 до 90 г на жителя в день. Стоимость питания выросла с 9,20–11,14 до 11,01–12,15 австралийского доллара на жителя в день [61]. Качественное исследование той же группы, основанное на интервью с 20 жителями до и 18 после перехода, показало, что жители связывали возможность выбора в момент еды с ощущением контроля и самостоятельности [65].

Эти данные важны для российского спора по двум причинам. Во-первых, они не подтверждают опасения, что выбор неизбежно ухудшает состав потребления: в исследовании съеденные блюда из нового меню содержали чуть больше белковых продуктов и овощей. Во-вторых, они показывают и цену: выбор в момент еды увеличил производственные отходы и стоимость. Вывод о росте стоимости не переносится на российские условия напрямую (другие структура затрат, уровень цен, штат), но направление эффекта следует учитывать (толкование).

Близкий по смыслу результат получен в больничном питании. В частной больнице Брисбена переход к модели room service — пациент заказывает блюда из ресторанного меню по телефону и получает их приготовленными под заказ — по данным ретроспективного анализа аудитов и сравнения «до/после» сопровождался ростом потребления пищи и удовлетворённости при снижении отходов и стоимости питания

на пациента [66]. Больничный контекст отличается от учреждения долговременного проживания (короткое пребывание, другой состав пациентов), поэтому результат приводится как аналогия, а не как доказательство для ДСО и ПНИ.

5.4 Выбор, среда приёма пищи и пищевой статус

Кластерное рандомизированное исследование Nijs и соавт. (2006, Нидерланды; 178 жителей пяти домов без деменции) сравнило семейный стиль приёма пищи (общий стол, блюда на столе, жители накладывают себе сами, персонал ест вместе с ними) с обычной индивидуальной подачей. Через шесть месяцев качество жизни в основной группе было выше на 6,1 балла (95 % ДИ 2,1–10,3), масса тела — на 1,5 кг (0,6–2,4) [24]. Семейная подача — это М4 по шкале раздачи; исследование показывает эффект целого комплекса изменений, а не одного лишь выбора.

Crogan и соавт. (2013, США) сравнили два дома престарелых со сходным составом жителей: в одном (33 участника) внедрили систему доставки и выбора блюд Eat Right, другой (28 участников) служил группой сравнения. В основной группе выросли удовлетворённость питанием, уровень преальбумина ($p = 0,001$) и масса тела ($p = 0,029$) [67]. Дизайн пилотный, без рандомизации; результат правдоподобен, но не доказателен.

Divert и соавт. (2015, Франция) в серии из 12 экспериментальных обедов для 42 жителей домов престарелых проверили по отдельности четыре фактора: название блюда в меню, размер и разнообразие порции овощей, приправы на столе, декор и фоновую музыку. Удовлетворённость и потребление мяса или овощей росли, когда изменение касалось непосредственно того, что съедается (разнообразие на тарелке, приправы на столе); названия блюд и декор эффекта не дали [68]. Авторы исходят из того, что во французских домах престарелых меню, время, место приёма пищи и место за столом обычно навязаны жителю. Работа полезна как список дешёвых мер с проверенным и с непроверенным эффектом.

Систематические обзоры осторожнее отдельных исследований. Abbott и соавт. (2013) проанализировали 37 работ о вмешательствах в среде приёма пищи у пожилых в учреждениях; эффект на массу тела в объединённом анализе был статистически незначим, а изменения среды приёма пищи были связаны с увеличением потребления энергии на 181 ккал/сут (95 % ДИ от –5 до 367; $p = 0,06$) [69]. Кокрейновский обзор Herke и соавт. (2018) по вмешательствам в среде и организации приёма пищи у людей с деменцией в учреждениях включил 9 исследований (1502 участника) и оценил доказательность как низкую или очень низкую [70]. Общий вывод: вмешательства в организацию питания, включающие выбор, скорее улучшают удовлетворённость и потребление, чем ухудшают, но размер эффекта на пищевой статус невелик и плохо измерен.

5.5 Выбор и люди с тяжёлыми психическими расстройствами

Опасение, высказанное в петербургском сообщении, — жители «склонны к выбору популярных, но не самых полезных продуктов» [15] — имеет эмпирическую основу, но не ту, которую ему обычно приписывают. Метаанализ Teasdale и соавт. (2019; 58

исследований) показал, что люди с психотическими расстройствами и биполярным расстройством потребляют в среднем на 1332 кДж (около 318 ккал) в сутки больше энергии (95 % ДИ 487–2178 кДж) и на 322 мг больше натрия, чем контрольные группы; более высокое потребление энергии и натрия было связано с худшим качеством рациона [71]. Метаанализ объединяет исследования в разных условиях и не выделяет учреждения с нормированным продуктовым набором; его данные говорят о риске, а не о том, что вариативное меню в учреждении с нормированным продуктовым набором воспроизведёт этот риск. В учреждении выбор ограничен блюдами, которые составлены по нормам: житель выбирает между двумя блюдами из одной раскладки, а не между салатом и фастфудом (толкование).

Качественные исследования в учреждениях для людей с интеллектуальными нарушениями описывают тот же конфликт с другой стороны. В 17 полуструктурированных интервью с сотрудниками трёх небольших жилых домов (community homes) сотрудники стремились поощрять здоровое питание и одновременно уважать автономию жителей, особенно когнитивно нарушенных и получающих психотропные препараты; этому мешали нехватка знаний, времени и разноречивых подходов [72]. В швейцарском исследовании трёх учреждений (13 интервью с сотрудниками и родителями и 4 интервью об институциональной пищевой среде) на пищевое поведение жителей влияли степень самоопределения в питании, участие в приготовлении еды, подход учреждения к контролю массы тела и ресурсы, а на межличностном уровне — представления сотрудников и родителей о питании [73]. Оба исследования приходят к выводу, что ответом на риск нездорового выбора служит обучение персонала и работа с пищевой средой, а не отказ от выбора.

Для российского ПНИ отсюда следует практический вывод (рекомендация): если врач видит у конкретного жителя метаболический риск, он принимает решение о назначениях для этого жителя; ограничивать выбор всем жителям из-за риска части из них — непропорциональная мера, не основанная на данных.

5.6 Международные клинические рекомендации

Рекомендации Европейского общества клинического питания и метаболизма (ESPEN) по клиническому питанию и гидратации в гериатрии (Volkert и соавт., 2022) содержат 82 рекомендации. Для нашей темы существенны две их линии: питание пожилых в учреждениях должно быть привлекательным и соответствовать индивидуальным предпочтениям, а ограничительных диет у пожилых с недостаточностью питания или её риском следует избегать [74]. Рекомендации ESPEN по питанию при деменции (Volkert и соавт., 2024) содержат 40 рекомендаций, из них семь посвящены условиям в учреждениях: подготовка персонала, привлекательная еда с возможностью выбора, приятная среда приёма пищи [75].

Важна юридическая природа этих документов: это рекомендации профессионального общества для клиницистов, а не нормы. В российском праве они не действуют. Их ценность для доклада — в том, что они фиксируют профессиональный консенсус: выбор и индивидуальные предпочтения рассматриваются как элемент профилактики недостаточности питания, а не как угроза ей.

5.7 Отходы с тарелки как измеритель

Обзорное (scoping) исследование Roulston и соавт. (2026) систематизировало 33 источника (20 рецензируемых и 13 источников «серой» литературы) о пищевых отходах в учреждениях длительного ухода. Чаще всего измеряли отходы с тарелки (14 источников), обычно взвешиванием (10) или визуальной оценкой (6); интервенционных исследований по снижению отходов нашлось только три [76]. Для сравнения обзор приводит больничные данные: по нарративному обзору Williams и Walton (2011), медиана отходов с тарелки в 32 исследованиях составила 30 % [77]; в больничной литературе допустимым называют уровень 5–20 % в зависимости от системы подачи. Разброс в самих учреждениях ухода велик: в австралийском отчёте Byles и соавт. (2009), включённом в обзор, отходы с тарелки составили 7,5–24 % при первом и 4–15 % при втором измерении; в шведской работе Eriksson и соавт. (2017) — 23 % (13–34 %) [76]. Общепринятого целевого уровня для учреждений длительного ухода обзор не устанавливает.

Для российского учреждения отходы с тарелки — самый доступный показатель результата: их можно измерять визуальной шкалой или взвешиванием без лабораторных исследований и без медицинской лицензии. Сопоставление отходов до и после введения выбора — минимальная доказательная база, которую учреждение может собрать само (рекомендация, см. п. 7.9).

5.8 Текстуры и ограничения выбора

Канадское поперечное исследование M3 (Making the Most of Mealtimes; 32 дома длительного ухода в четырёх провинциях) показало, что пища изменённой консистенции назначена 47 % из 639 участников (298 человек); такие жители чаще имели дисфагию, риск недостаточности питания, деменцию и зависимость в повседневной активности [78]. Это число приводится как контекст, а не как оценка для российских учреждений: доля таких жителей в российском ПНИ или доме-интернате не измерялась публично. Совокупно с работой Abbey и соавт. [64] оно показывает, что вариативное меню, придуманное для ходячих и говорящих жителей, может не дойти до половины дома. Решения о консистенции — клинические и в этом докладе не рассматриваются.

5.9 Организационные факторы

Porter, Ottrey и Huggins (2017) проанализировали защищённое время приёма пищи (protected mealtimes) — запрет на неотложные процедуры во время еды; доказательства его эффекта на потребление оказались неоднородными [79]. Namasaki и соавт. (2023, Япония) в когорте из 2909 жителей 235 домов длительного ухода на данных страховых требований префектуры Ибараки (2018–2019) показали, что большее число диетологов в штате связано с меньшей вероятностью потенциально предотвратимых госпитализаций в первые 180 дней после поступления (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97) [80]. Связь наблюдательная и не доказывает причинности, но согласуется с представлением о том, что качество питания определяется кадрами не меньше, чем нормами. Keller и соавт. (2022) переложили рекомендации

по питанию в учреждениях долговременного ухода на 27 практических мер и оценили их осуществимость: высоко осуществимыми признаны 6 мер, умеренно — 12, низко — 9, главным образом из-за потребности в дополнительном или квалифицированном персонале, финансировании и инфраструктуре; авторы делают вывод, что без государственного финансирования, политики и стандартов улучшение питания в учреждениях ограничено [81].

5.10 Стоимость

Hugo и соавт. (2018) опросили 817 австралийских учреждений долговременного ухода. Средняя стоимость кейтеринга составила 8,00 австралийского доллара на жителя в день, из них на продукты (сырьё) — 6,08 доллара [82]. В докладе «Не просто накормить» 8 долларов названы стоимостью сырья [16]; по тексту статьи это стоимость всего кейтеринга. Уточнение вносится во вторую редакцию.

Прямой пересчёт австралийских цифр в рубли некорректен: различаются цены, состав затрат и структура учреждений. Значимо соотношение: в исследовании Wheeler и соавт. переход на выбор в момент еды увеличил стоимость примерно на 9–20 % (нижняя граница диапазона выросла на 20 %, верхняя — на 9 %; расчёт автора по данным [61]). Российских опубликованных расчётов стоимости вариативного меню не найдено.

5.11 Чего наука не знает

Рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях длительного пребывания, аналогичных российским ПНИ, найти не удалось. Почти все данные получены в домах престарелых Австралии, Европы и Северной Америки, где жители старше, а доля людей с психическими расстройствами без деменции ниже. Перенос выводов на ПНИ — экстраполяция.

Нет исследований, сравнивающих разные числа вариантов (два, три, семь) в одном дизайне. Нет данных о том, как выбор влияет на пищевое поведение людей с интеллектуальными нарушениями в учреждениях; опасение, что такие жители будут систематически выбирать «вредное», остаётся непроверенным предположением. Наконец, все исследования стоимости проведены в странах, где питание финансируется иначе, чем в российском государственном задании.

5.12 Сводная таблица

Работа	Страна, дизайн	Выборка	Ключевой результат	Ограничения
Cereda и соавт., 2016 [62]	Метаанализ	240 иссл., 113 967 чел.	Недостаточность питания 17,5 % в домах престарелых, 28,7 % в LTC	Разнородность выборок
Горелик и соавт., 2020 [33]	Россия, наблюдение	97	Риск 72,1 %, недостаточность 10,4 %	Нет контроля

Работа	Страна, дизайн	Выборка	Ключевой результат	Ограничения
Wright и соавт., 2013 [63]	Австралия, поперечное	313	Больше вариантов и выбор ближе к еде — выше удовлетворённость	Поперечный дизайн
Abbey и соавт., 2015 [64]	Австралия, поперечное	247 учреждений; 161 меню; 36 приёмов пищи	Выбор низок, особенно при протёртой пище	Описательный дизайн
Nijs и соавт., 2006 [24]	Нидерланды, кластерное РКИ	178	КЖ +6,1; масса +1,5 кг	Без деменции; комплексное вмешательство
Croghan и соавт., 2013 [67]	США, два дома, без рандомизации	61 (33 + 28)	Рост преальбумина и массы	Без рандомизации
Divert и соавт., 2015 [68]	Франция, эксперимент	42 жителя, 12 обедов	Разнообразие на тарелке и приправы помогают; названия и декор — нет	Малая выборка
Abbott и соавт., 2013 [69]	Систематический обзор	37 работ	+181 ккал/сут ($p = 0,06$); масса — без эффекта	Неоднородность
Herke и соавт., 2018 [70]	Кокрейновский обзор	9 РКИ, 1502	Низкая доказательность	Деменция
Wheeler и соавт., 2025 [61]	Австралия, до/после	Одно учреждение	Удовлетворённость 3,60 → 4,57; белок +5 г на приём пищи; стоимость +9–20 %	Одно учреждение
Roulston и соавт., 2026 [76]	Обзор	33 источника	Отходы с тарелки — основной измеритель; интервенций всего три	Разные методы измерения
Hamasaki и соавт., 2023 [80]	Япония, когорта	2909	Больше диетологов — меньше предотвратимых госпитализаций (HR 0,72)	Наблюдательный дизайн
Teasdale и соавт., 2019 [71]	Метаанализ	58 исследований	При ТПР энергия +1332 кДж/сут, натрия +322 мг	Не учреждения; не выбор
McCray и соавт., 2018 [66]	Австралия, больница, до/после	Аудиты	Room service: потребление и удовлетворённость выше, отходы и стоимость ниже	Больничный контекст

6 Зарубежное регулирование

6.1 Зачем и с какой осторожностью

Зарубежные нормы не действуют в России, и ссылка на них не может заменить российского основания для решения учреждения. Их ценность иная: они показывают, какие формулировки права на выбор оказались юридически работоспособными, какие измеримые требования к питанию в учреждениях долговременного ухода устанавливают другие правовые порядки и где эти требования сталкиваются с теми же противоречиями, что и в России. Первая редакция обзора упоминала зарубежный опыт кратко и включала раздел о «практике стран СНГ» без источников [1]; во второй редакции этот раздел не воспроизводится, а зарубежный блок построен по первоисточникам.

6.2 Англия: регламент CQC

Регламент 2014 г. о регулируемой деятельности в здравоохранении и социальном уходе (The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014), надзор за исполнением которого осуществляет Care Quality Commission, в регламенте 14 «Meeting nutritional and hydration needs» определяет потребности в питании как совокупность четырех элементов: получение подходящей и питательной пищи и питья, достаточных для поддержания жизни и здоровья; получение парентерального питания и пищевых добавок по назначению специалиста; удовлетворение «любых разумных требований» получателя услуг к еде и питью, вытекающих из его предпочтений или религиозной и культурной принадлежности; помощь в еде и питье, если она нужна [83].

Конструкция поучительна тремя чертами. Предпочтения названы составной частью «потребности в питании», а не дополнительной услугой. Требования ограничены критерием разумности. Наконец, регламент 14(3) устанавливает пределы: обязанность не применяется, если её исполнение нарушило бы требование о согласии (регламент 11) или противоречило бы наилучшим интересам человека, определяемым по Закону о дееспособности 2005 г. [83]. Иначе говоря, английское право прямо решает коллизию «выбор против здоровья» через процедуру оценки наилучших интересов, а не через запрет выбора.

6.3 Шотландия: стандарты здравоохранения и социального ухода

Стандарты здравоохранения и социального ухода Шотландии (Health and Social Care Standards, 2017) сформулированы от первого лица. Стандарт 1.33: «Я могу выбирать подходящие, хорошо поданные и здоровые блюда и перекусы, включая свежие фрукты и овощи, и участвовать в планировании меню». Соседние стандарты 1.34–1.39 касаются достойной помощи при еде, возможности есть не спеша, совместной еды, учёта культурных и религиозных потребностей, возможности готовить самому

и доступа к воде в любое время [84]. Методические материалы Care Inspectorate по питанию в учреждениях ухода содержат практические ориентиры, в том числе интервал не менее четырёх часов между основными приёмами пищи [84].

Шотландские стандарты интересны как прецедент формулировки права, удобной для проверки: проверяющий спрашивает жителя, может ли он выбирать, и сопоставляет ответ с наблюдением. Российские нормы, напротив, обращены к учреждению и измеряются граммами.

6.4 США: федеральные требования к домам сестринского ухода

Требования к домам сестринского ухода, участвующим в программах Medicare и Medicaid (42 CFR § 483.60), обязывают обеспечить каждому жителю питательную, вкусную, сбалансированную диету «с учётом предпочтений каждого жителя» [85]. Меню должны составляться заранее и соблюдаться, отражать религиозные, культурные и этнические потребности и мнения жителей и их объединений, пересматриваться диетологом; при этом прямо сказано, что ничто в требованиях к меню не ограничивает права жителя на личный выбор в питании (§ 483.60(c)(7)). Жителю, который отказывается от поданного блюда или просит другое, должны предлагаться привлекательные альтернативы сходной пищевой ценности (§ 483.60(d)(5)). Пища должна учитывать аллергии, непереносимость и предпочтения. Между полноценным ужином и завтраком должно проходить не более 14 часов; если перед сном подаётся питательный перекус и группа жителей согласна, — до 16 часов. Жителям, желающим есть вне установленного времени, должны предоставляться подходящие альтернативные блюда и перекусы [85].

Американская норма — наиболее точный зарубежный аналог российского понятия «вариативное меню»: она требует не выбора из двух блюд на каждый приём пищи, а гарантированной альтернативы «сходной пищевой ценности» по запросу. Это решает проблему соблюдения норм: альтернатива по определению эквивалентна основному блюду.

6.5 Канада, Онтарио: регламент о долгосрочном уходе

Регламент Онтарио O. Reg. 246/22 к Закону о совершенствовании долгосрочного ухода 2021 г. (Fixing Long-Term Care Act) в разделе 77 устанавливает требования к меню [86]. Цикл меню должен длиться не менее 21 дня и включать меню для обычного, лечебного и изменённого по консистенции питания; на каждом приёме пищи и перекусе предлагается выбор напитков; на каждом из трёх основных приёмов — не менее одного основного блюда и гарнира, а также выбор других основных блюд и гарниров, «чтобы удовлетворить конкретные потребности или пищевые предпочтения жителей»; на обед и ужин — десерт и выбор других десертов; выбор перекусов днём и вечером. До введения в действие каждый цикл рассматривается советом жителей, оценивается менеджером по питанию и диетологом и утверждается диетологом с учётом предпочтений жителей и норм потребления; результаты оценки документируются. Время приёма пищи согласуется с советом жителей; еда и напитки,

включая воду, соответствующие рациону жителей, доступны круглосуточно; для жителя, чьи потребности не покрываются циклом, разрабатывается индивидуальное меню [86].

Онтарийская норма показывает, что выбор и цикличность совместимы: цикл в 21 день сам по себе предусматривает альтернативы на каждом приёме пищи. Она также показывает разграничение, которое в российском праве отсутствует: вариативность (выбор в рамках цикла для всех) и персонализация (индивидуальное меню для того, кому цикл не подходит) закреплены в разных пунктах одного раздела.

6.6 Австралия: усиленные стандарты качества

С 01.11.2025, с вступлением в силу Закона об уходе за пожилыми 2024 г., в Австралии действуют усиленные стандарты качества; стандарт 6 посвящён питанию и включает право человека влиять на то, что, когда, где и как он ест [87]. До реформы федеральное правительство с 2021 г. выплачивало учреждениям надбавку к базовой суточной плате в размере 10 австралийских долларов на жителя в день при условии отчётности о расходах на питание [87]. Австралийская система интересна как пример, где выбор в питании стал предметом государственного стандарта после серии исследований, показавших низкий уровень реального выбора [64].

6.7 Германия и Австрия: стандарты профессиональных обществ

Стандарт качества Немецкого общества питания (DGE) для питания в учреждениях для пожилых (DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Senioreneinrichtungen) рекомендует учитывать пищевую биографию жителя (Essbiografie), предусматривать блюда по желанию и использовать цикл меню продолжительностью не менее четырёх недель [88]. Стандарт не является законом; в ряде федеральных земель он используется как ориентир при контроле. Австрийские стандарты качества питания в учреждениях ухода (2022) по аналогии рекомендуют учитывать предпочтения и избегать необоснованных ограничений рациона [89].

6.8 Швеция и Япония

Национальное продовольственное агентство Швеции (Livsmedelsverket) в рекомендациях по питанию в учреждениях для пожилых указывает, что ночной перерыв в приёме пищи не должен превышать 11 часов [90]. Это ориентир, а не обязательная норма; его ценность для российского учреждения — в сопоставлении с американским пределом 14–16 часов и с рекомендацией постановления № 12 не допускать длительного перерыва между ужином и завтраком [25].

В Японии с 2005 г. в системе страхования долговременного ухода оплачивается управление питанием (栄養マネジメント) в учреждениях, а с 2021 г. действует система сбора данных LIFE (Long-term care Information system For Evidence), в которую учреждения передают сведения о пищевом статусе жителей [91]. Японский пример показывает другой путь: не норма о выборе, а финансовый стимул за измерение и управление питанием.

6.9 Сводная таблица

Правопорядок	Акт	Формулировка выбора	Измеримые требования	Юридическая сила
Англия	Регламенты 2014 г., рег. 14 [83]	Разумные требования из предпочтений, религии, культуры — часть потребности в питании	Ограничение наилучшими интересами	Обязательна
Шотландия	Health and Social Care Standards 2017, 1.33–1.39 [84]	«Я могу выбирать... и участвовать в планировании меню»	Вода в любое время; ориентир 4 ч между приёмами	Стандарты, учитываются при инспекции
США	42 CFR § 483.60 [85]	Альтернатива сходной пищевой ценности по запросу	≤14 ч (16 ч с перекусом)	Обязательна для участников Medicare/Medicaid
Онтарио	O. Reg. 246/22, разд. 77 [86]	Выбор основных блюд, гарниров, напитков на каждом приёме; десертов и перекусов	Цикл ≥21 дня; рассмотрение советом жителей; индивидуальное меню	Обязательна
Австралия	Усиленные стандарты качества, стандарт 6 [87]	Влиять на что, когда, где и как есть	Отчётность о расходах на питание	Обязательна
Германия	Стандарт DGE [88]	Пищевая биография, блюда по желанию	Цикл ≥4 недель	Рекомендация
Швеция	Рекомендации Livsmedelsverket [90]	—	Ночной перерыв ≤11 ч	Рекомендация
Япония	Система страхования ухода; LIFE [91]	—	Финансирование управления питанием	Финансовый механизм
Россия	442-ФЗ, 935н, СанПиН 4282-26, региональные нормы	Нет нормы о выборе блюд	Не менее 3 приёмов пищи; нормы в граммах	Обязательны

6.10 Выводы для российской дискуссии

Ни одна из рассмотренных систем, кроме Онтарио, не требует выбора на каждом приёме пищи; онтарийская норма при этом не фиксирует число вариантов. Общий знаменатель иной: учёт предпочтений как часть понятия адекватного питания (Англия, США), альтернатива эквивалентной пищевой ценности (США), участие жителей в планировании меню (Шотландия, США, Онтарио) и процедуры, в которых меню с выбором проверяет и утверждает диетолог (Онтарио, США), а питание измеряется и оплачивается как управляемый процесс (Япония). Для российского нормотворца — если он решит регулировать выбор — американская формула «альтерна-

тива сходной пищевой ценности» снимает основное возражение о несовместимости выбора с нормами, а онтарийская процедура утверждения цикла диетологом с участием совета жителей отвечает на опасение о вреде выбора (рекомендация автора; не позиция какого-либо органа).

7 Практика: десять операционных сценариев

7.1 Как читать раздел

Сценарии ниже описывают решения, которые учреждение может принять самостоятельно в рамках действующих норм. Каждый сценарий завершается указанием класса: что в нём норма, что толкование, что рекомендация. Числовые примеры — иллюстративная арифметика автора на основе норм постановления № 1284 и таблицы замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26; это не расчёты конкретного учреждения и не данные о фактических затратах. Клинические решения (диеты, консистенции, назначения) в сценариях не рассматриваются: там, где они возникают, указано, что решение принимает врач.

7.2 Сценарий 1. Два вторых блюда в пределах нормы № 1284

Задача. Ввести на обед три дня в неделю выбор между мясным и рыбным вторым блюдом, не нарушив нормы питания.

Что говорит норма. Постановление № 1284 устанавливает суточные количества по группам продуктов: для домов-интернатов общего типа мясо (говядина, свинина) — 90 г нетто, рыба — 41,8 г нетто, птица — 40 г нетто [27]. Норма суточная; учреждения, как правило, контролируют её выполнение по среднему за период (неделя, декада, месяц) через накопительную ведомость. Способ контроля в постановлении не определён (п. 3.11).

Иллюстрация. Учреждение на 100 жителей. Недельная потребность по норме: мясо $90 \times 7 \times 100 = 63,0$ кг нетто, рыба $41,8 \times 7 \times 100 = 29,26$ кг нетто. Предположим, в базовом меню на обед все три дня подаётся мясное второе с закладкой 75 г нетто мяса на порцию. Вводится альтернатива — рыба (треска). По таблице замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26 100 г говядины эквивалентны по пищевой ценности 125 г трески [3]; следовательно, 75 г говядины соответствуют примерно 94 г трески. Если рыбу выберут 40 % жителей, за неделю расход мяса уменьшится на $0,4 \times 100 \times 75 \text{ г} \times 3 = 9,0$ кг, расход рыбы увеличится на $0,4 \times 100 \times 94 \text{ г} \times 3 \approx 11,3$ кг. Итог недели: мясо 54,0 кг (85,7 % нормы), рыба 40,5 кг (138,6 % нормы).

Вывод из иллюстрации. По пищевой ценности замена эквивалентна; по групповой норме — нет: мясо недовыполнено на 14 %, рыба перевыполнена на 39 %. Если проверяющий сверяет выполнение норм по группам, расхождение будет замечено. Есть три способа его снять:

1. Закрепить в локальном акте учреждения, что выполнение норм оценивается с учётом замен по утверждённой таблице (с прямой ссылкой на источник таблицы) и в накопительной ведомости показывать пересчёт заменённых количеств в базовый продукт.
2. Компенсировать отклонение в общем меню: сократить рыбный день или уменьшить закладку рыбы в другие дни.
3. Строить пару внутри одной группы (сценарий 2).

Первый способ опирается на аналогию: таблица замен приложения № 11 к СанПиН 4282-26 нормативно относится к питанию детей (подп. 4 п. 59) [3], а для взрослых её применение — решение учреждения. Ближайший федеральный документ для взрослых — приложения № 7 и № 8 к рекомендациям, утверждённым постановлением № 12 [25]. Ссылку на источник таблицы следует указать в самом локальном акте.

Классы. Норма — суточные количества № 1284. Толкование — допустимость контроля по среднему за период и применения таблицы замен по аналогии. Рекомендация — локальный акт о порядке учёта замен.

7.3 Сценарий 2. Пары внутри одной группы продуктов

Задача. Ввести выбор, который вообще не требует пересчёта норм.

Решение. Подбирать варианты из одной нормативной группы постановления № 1284 [27]:

Группа № 1284	Пары, не требующие пересчёта	Пример из практики
Крупы, бобовые	Гречка / рис / пшено / овсянка	«Рис или гречка» — Усть-Илимск [10]
Говядина, свинина	Котлета / тефтели / гуляш из одной заготовки	«Два мясных блюда на выбор» — Успенский ПНИ [7]
Овощи (все виды, включая консервированные и зелень)	Винегрет / салат из свёклы / салат из свежих овощей	Успенский ПНИ [7]
Чай, кофе, какао	Чай / какао / кофейный напиток	Болотнинский ПНИ [5]
Птица	Курица жареная / отварная	Болотнинский ПНИ, 2026 [6]

Пара «гуляш или печень по-строгановски» из усть-илимского меню [10] — между группами: печень в постановлении № 1284 не входит в группу «говядина, свинина». Для неё нужна таблица замен: по приложению № 11 к СанПиН 4282-26 100 г говядины эквивалентны 116 г говяжьей печени [3].

Вторая полезная граница — технологический поток. Два варианта из одной заготовки (котлета и тефтели из одного фарша) не требуют дополнительной плиты и дополнительной закупки; два варианта из разных потоков (котлета и рыба) требуют второго технологического процесса, отдельных ТТК и, как правило, дополнительного оборудования или времени повара.

Классы. Норма — группы продуктов № 1284. Рекомендация — подбор пар внутри группы и потока.

7.4 Сценарий 3. Заказ накануне или выбор в момент еды

Два режима. При заказе накануне (М1) житель выбирает рацион следующего дня по листу заказа; кухня готовит под известные объёмы. Так устроена петербургская практика, описанная Комитетом по социальной политике [15]. При выборе в момент еды (М2) житель выбирает на линии раздачи; кухня готовит под прогноз. Так устроены новосибирские и усть-илимская практики [5, 7, 10].

Что говорят данные. По Wright и соавт., удовлетворённость выше, когда выбор ближе к приёму пищи [63]. По Wheeler и соавт., переход к выбору в момент еды увеличил производственные отходы с 55 до 90 г на жителя в день [61].

Санитарное ограничение. СанПиН 4282-26 не допускает реализации готовых блюд на следующий день и замораживания нереализованных блюд (п. 32) [3]. Всё, что приготовлено под прогноз и не роздано, становится отходом. Поэтому выбор в момент еды требует прогнозирования объёмов.

Иллюстрация прогноза. Старт — 50/50 с небольшим резервом на каждый вариант. Каждый день фиксируется фактическое распределение выбора и число жителей, которым не хватило выбранного варианта. Через две-три недели пропорции корректируются по статистике. Индикатор качества прогноза — доля жителей, не получивших выбранный вариант; она должна стремиться к нулю. Индикатор потерь — масса нерозданных порций.

Компромисс. Заказ накануне для маломобильных жителей, получающих пищу в комнатах (именно так это сделано в правилах внутреннего распорядка ДСО «Серафимовский» [22]), и выбор в момент еды в столовой.

Классы. Норма — п. 32 СанПиН 4282-26. Толкование — выводы из исследований. Рекомендация — прогноз, индикаторы, смешанный режим.

7.5 Сценарий 4. Раздача и персонал

Санитарные требования. Готовые блюда, требующие разогрева, не могут находиться на раздаче более трёх часов с момента изготовления; к приготовлению, порционированию и раздаче не допускаются посторонние лица, «включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности» (п. 32 СанПиН 4282-26) [3]. Работники, занятые изготовлением пищи и контактирующие с пищевой продукцией, должны проходить гигиеническую подготовку и медицинские осмотры (п. 24) и ежедневный осмотр с записью в гигиеническом журнале (п. 25) [3].

Следствие для вариативного меню. Если выбор организуется в отделениях (на подносах, в буфетных жилых корпусов), то санитары или младшие медицинские сёстры, которые порционируют второй вариант, должны иметь раздачу в должностных обязанностях и пройти гигиеническую подготовку. Это частая скрытая проблема: при едином меню в отделение привозят готовые порции, а при выборе персонал отделения начинает порционировать.

Раздача маломобильным. Выбор, существующий только в столовой, не доходит до жителей, которые в столовую не ходят. Два рабочих решения: лист заказа накануне (сценарий 3) или подача на подносе обоих вариантов малыми порциями с последующим выбором — второе требует решения вопроса об остатке. Доклад «Не просто накормить» формулирует правило «два варианта на подносе, а не вторая линия в коридоре» [16] — это рекомендация.

Время. Если выбор в момент еды увеличивает время раздачи, нужно проверить, укладывается ли последняя порция в три часа с момента изготовления; при необходимости — готовить партиями.

Классы. Нормы — п. 24, 25, 32 СанПиН 4282-26. Рекомендация — правка должностных инструкций, подносы для маломобильных.

7.6 Сценарий 5. Санитарный паспорт каждого варианта

Каждое блюдо, которое предлагается на выбор, — самостоятельный объект санитарного контроля. Для каждого варианта учреждение должно иметь:

- технологический документ (технологическую или технико-технологическую карту), утверждённый руководителем, причём наименование блюда в меню должно совпадать с наименованием в технологическом документе (п. 11 СанПиН 4282-26) [3];
- запись в журнале бракеража готовой продукции: блюдо не выдаётся до устранения нарушений технологии (подп. 13 п. 56) [3];
- суточную пробу. Для медицинских организаций подп. 4 п. 56 требует отбирать пробу «от каждой партии приготовленной пищевой продукции», отдельно каждое блюдо; для организаций социального обслуживания прямо предусмотрен отбор суточных проб при получении готовых блюд от сторонней организации (подп. 12 п. 56) [3]. Для собственного пищеблока организации социального обслуживания прямой нормы об отборе проб в разделе VII нет (п. 2.7). Учреждению, вводящему второй вариант, разумно отбирать пробу каждого варианта (рекомендация): при пищевом отравлении отсутствие пробы одного из вариантов сделает невозможным установление источника;
- сведения об аллергенах, если блюдо содержит ингредиенты с аллергенными свойствами (п. 43) [3].

Классы. Нормы — п. 11, 43, подп. 12–13 п. 56. Рекомендация — проба каждого варианта на собственном пищеблоке.

7.7 Сценарий 6. Закупки: 44-ФЗ и 223-ФЗ

Различие контуров. Бюджетное учреждение закупает продукты по 44-ФЗ; автономное учреждение — по 223-ФЗ и своему положению о закупке, за исключением случаев, когда закупка финансируется субсидией на капитальные вложения (ч. 4 ст. 15 44-ФЗ) [41, 42]. В Санкт-Петербурге ДСО «Серафимовский» (автономное учреждение) закупает по 223-ФЗ, а ДСО «Тесовый берег» (бюджетное) — по 44-ФЗ: извещение № 0372200070825000244 от 24.11.2025 о поставке продуктов питания размещено как открытый конкурс [45].

Проблема выбора в контракте. При выборе объёмы отдельных продуктов колеблются: если 40 % жителей выбирают рыбу, рыбы нужно больше, мяса меньше (сценарий 1). Контракт с жёстко зафиксированными количествами по позициям этого не выдерживает.

Инструменты 44-ФЗ. Если количество товара невозможно определить заранее, заказчик вправе указать в извещении цену единицы товара и максимальное значение цены контракта (ч. 24 ст. 22 44-ФЗ); количество в этом случае определяется заявками заказчика в пределах цены контракта [41]. Кроме того, если такая возможность предусмотрена извещением и контрактом, количество товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на 10 % с соразмерным изменением цены (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ) [41]. Для вариативного меню удобнее первый инструмент: он позволяет перераспределять заказ между позициями по фактическому спросу.

Инструменты 223-ФЗ. Положение о закупке учреждения само определяет способы закупки и порядок изменения договора [42]. Автономное учреждение может предусмотреть рамочные договоры с ценой единицы и заявочной поставкой. Это делает 223-ФЗ более гибким контуром для выбора, но гибкость определяется текстом положения, а не законом.

Спецификация. Для обоих контуров выбор живёт в спецификации: группы взаимозаменяемых продуктов, пропорции по статистике выбора, допустимые замены. Избыточная детализация (конкретная торговая марка, необоснованные характеристики) может ограничить конкуренцию и стать предметом жалобы.

Аутсорсинг. Если питание передано организатору питания, выбор существует только тогда, когда он записан в техническом задании. Доклад «Не просто накормить» предлагает восемь строк ТЗ: группы взаимозаменяемых продуктов; пропорции по статистике выбора; обязательность не менее двух вариантов в определённых приёмах пищи; порядок замен с актом; требования к качеству для изменённых консистенций; приёмка и пробы; цикл меню с массой порций; ежемесячная отчётность о доле выбора и остатках [16]. Ответственность за суточные пробы, бракераж и учёт жителей с нарушениями глотания поставщику не передаётся (рекомендация).

Классы. Нормы — ч. 4 ст. 15, ч. 24 ст. 22, ст. 95 44-ФЗ; 223-ФЗ. Толкование — применимость к вариативному меню. Рекомендация — спецификация и ТЗ.

7.8 Сценарий 7. Комплект документов для проверяющего

Проверяющий оценивает документы и факты, а не намерения. Для вариативного меню разумно иметь до начала пилота следующий комплект (рекомендация):

1. Локальный акт (приказ или раздел правил внутреннего распорядка) о порядке организации вариативного питания, с определением выбора, перечнем приёмов пищи с выбором, порядком учёта и ответственными. Пример локальной формы — правила внутреннего распорядка ДСО «Серафимовский», утверждённые приказом № 124 [22]; это не образец для обязательного применения.
2. Утверждённое цикличное меню с указанием вариантов.
3. Таблица замен с указанием источника и расчёт выполнения норм за период с учётом замен.
4. Технологические документы на каждый вариант.
5. Журналы бракеража и суточных проб с записями по каждому варианту.

6. Учёт выбора: лист заказа (при заказе накануне) или ежедневная статистика распределения выбора.
7. Протоколы совета (комиссии) по питанию, если такой создан.
8. Письмо учредителю об изменении организации питания (если это требуется уставом или порядком взаимодействия с учредителем).

Типовые вопросы и ответы. «Почему подают не по меню?» — Варианты включены в утверждённое меню. «Где выполнение норм?» — Накопительная ведомость с пересчётом замен. «Кто разрешил?» — Локальный акт учреждения, принятый в пределах его компетенции по уставу. Ответ «так теперь везде» или «так рекомендует Минтруд» неверен: федеральной нормы о вариативном меню нет.

Роспотребнадзор оценивает соблюдение обязательных санитарных требований (температура, пробы, поточность, сроки), а оценка соблюдения рекомендательных норм СанПиН не может быть предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (п. 3 СанПиН 4282-26) [3].

7.9 Сценарий 8. Экономика: что можно утверждать и как измерять

Что известно. Российских опубликованных расчётов стоимости вариативного меню нет (п. 4.10). Зарубежные данные: в исследовании Wheeler и соавт. стоимость выросла с 9,20–11,14 до 11,01–12,15 австралийского доллара на жителя в день, производственные отходы — с 55 до 90 г [61]. Средняя стоимость кейтеринга в австралийских учреждениях — 8,00 доллара в день, из них сырьё — 6,08 доллара [82].

Где возникают затраты (толкование). Сырьё при парах внутри группы перераспределяется, а не растёт (сценарий 2). Дополнительные затраты возникают в трёх местах: производственные отходы при выборе в момент еды; время персонала на раздаче и учёте; оборудование для второго технологического потока или для доставки в отделение. Петербургское сообщество называет оборудование и сотрудников [15].

Иллюстративная арифметика потерь. Если перенести на учреждение на 300 жителей прирост производственных отходов из исследования Wheeler и соавт. (+35 г на жителя в день), получится около 10,5 кг готовой пищи в день. Это не прогноз, а порядок величины, который стоит проверить собственным замером [61].

Масштаб в петербургских ценах. Тариф 2025 г. на обеспечение питанием в стационарной форме (кроме ПНИ) — 560,87 руб. в день, для ПНИ — 571,63 руб. в день [53]. Если допустить, что организация выбора увеличит расходы на питание на 10–20 % — допущение, близкое к результату Wheeler и соавт. [61], — это составит около 56–114 руб. на жителя в день, или 1,7–3,4 млн руб. в месяц на учреждение в 1 000 мест (иллюстративная арифметика: $560,87 \times 0,1...0,2 \times 1\,000 \times 30$). Это не прогноз: австралийский прирост включал производственные отходы и персонал в австралийских условиях, а российские кейсы (п. 4.10) показывают, что стартовый формат вводился и без публично названных дополнительных расходов. Арифметика показывает лишь, почему полный переход крупного учреждения — вопрос учредителя, а не только кухни.

Как измерять. Минимальная система учёта, доступная любому учреждению (рекомендация):

- отходы с тарелки — визуальная оценка по шкале «съедено всё / $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$ / ничего» по выборке жителей или взвешивание остатков в течение 7 дней до запуска и 7 дней через месяц после;
- производственные отходы — масса нерозданных порций по каждому варианту ежедневно;
- распределение выбора — ежедневно;
- стоимость — фактические расходы на продукты на одного жителя в день за месяц до и месяц после.

7.10 Сценарий 9. Пилот на 90 дней

Конструкция. Доклад «Не просто накормить» предлагает пилот на одном отделении (20–35 жителей), в одном приёме пищи (обычно обед), 2–3 дня в неделю, с заказом накануне на старте [16]:

Дни	Действия
1–14	Приказ о пилоте; замер «до» (отходы, распределение предпочтений по опросу); инструктаж персонала; уведомление учредителя; при аутсорсинге — сверка контракта
15–75	Два варианта второго блюда 2–3 дня в неделю; журналы с первого дня; еженедельный разбор
76–90	Сводка показателей; обсуждение с жителями; решение: расширить, закрепить или свернуть с указанием причин

Что доказывает пилот. Исполнимость и безопасность в конкретном учреждении, но не эффект выбора на пищевой статус: для этого нет контрольной группы и мало времени. Возможные систематические ошибки: эффект наблюдения (первые недели), сезонность, «своя» смена.

Критерии немедленной остановки (рекомендация): рост отказов от еды; санитарные нарушения на новой линии; противопоказание врача для конкретного жителя (в этом случае прекращается участие жителя, а не пилот).

Расхождение календарей. Предшествующая работа семинара предлагала дорожную карту на 12–24 месяца с пилотом на 11–14 месяцах [17]; доклад «Не просто накормить» сжимает старт до 90 дней на одном отделении [16]. Это разные масштабы задачи (перестройка всего дома против пилота), а не ошибка одной из работ.

7.11 Сценарий 10. Невербальный выбор, отказ, пост и ночной интервал

Невербальный выбор. Вариативное меню, построенное на вопросе «что будете?», исключает тех, кто не может ответить словами. Исследование Abbey и соавт. показало, что реальный выбор особенно низок у жителей на протёртой пище [64]. Доклад «Не просто накормить» предлагает четыре канала выяснения предпочтений: показ двух реальных порций с фиксацией реакции; наблюдение за тем, что съедается, по серии записей; пищевую биографию периода, когда человек мог выразить предпочтения; сведения от близких и давних сотрудников [16]. В самом докладе есть внутреннее противоречие о порядке этих каналов: в одном месте приоритет отдан зафиксированной биографии, в другом — текущему выраженному предпочтению [16, 17]. Автор не снимает его в этой редакции: решение требует этической и правовой проработки, в том числе с учётом дееспособности и роли законного представителя.

Отказ от еды. Доклад «Не просто накормить» предлагает проект правила: каждый отказ фиксируется; в тот же приём предлагается альтернатива; три отказа подряд — осмотр врача в тот же день; системный недоед (не менее 25 % порции в течение недели) — врач и пересмотр плана; отказ от воды — немедленно [16]. Это проект локального правила, а не норма российского права; клиническая часть — компетенция врача. Наличие альтернативы в вариативном меню облегчает второй шаг правила.

Пост и религиозные ограничения. Для ПНИ право соблюдать религиозные каноны, включая пост, если это не нарушает внутреннего распорядка, закреплено ч. 2 ст. 37 Закона № 3185-1 в силу ст. 43 [20]. С 01.09.2025 обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов возложена на все организации социального обслуживания подп. 15 п. 20 Правил, утверждённых приказом № 305н [21]. Организационно это означает три вопроса, на которые учреждение должно иметь письменный ответ: как житель заявляет о соблюдении поста (заявление, отметка в индивидуальной программе или устное сообщение, зафиксированное сотрудником); какие постные блюда входят в меню на период поста и по каким технологическим документам они готовятся; как выполнение норм по белоксодержащим группам (мясо, молоко, яйцо) обеспечивается заменой на рыбу в разрешённые дни, бобовые и другие продукты по утверждённой таблице замен (рекомендация). Вариативное меню позволяет реализовать это право без отдельной «постной кухни»: постное блюдо становится одним из вариантов. Если у жителя есть медицинские назначения, вопрос о посте согласуется с врачом.

Ночной интервал. Для взрослых в организациях социального обслуживания Сан-ПиН 4282-26 устанавливает только минимальную кратность — не менее трёх раз в день (подп. 11 п. 56) [3]. Рекомендации, утверждённые постановлением № 12, предписывают не допускать длительных перерывов, «особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего дня», без числового предела [25]. Зарубежные ориентиры: не более 14 часов (16 часов при перекусе) в США [85], не более 11 часов в шведских рекомендациях [90]. Доклад «Не просто накормить» использует рабочий

ориентир не более 13 часов [16] — это ориентир, а не норма. Выбор блюда не компенсирует долгого ночного перерыва; если ужин подаётся в 17:30, а завтрак в 8:30, интервал составляет 15 часов, и это проблема организации режима, а не меню.

7.12 Инструменты измерения: что существует и что из этого применимо

Сценарии 8 и 9 требуют измерений, а российские кейсы (п. 4.10) их не публикуют. Причина отчасти в том, что в отечественной практике социального обслуживания нет общепринятых инструментов для оценки питания с точки зрения жителя. В зарубежной литературе они есть; ниже описаны те, чьи свойства проверены по публикациям, с оценкой применимости. Валидированных русскоязычных версий этих инструментов найти не удалось, поэтому их использование в российском учреждении — адаптация, а не готовая методика (рекомендация).

Четыре объекта измерения. Вариативное меню затрагивает четыре разных предмета, и смешивать их нельзя: что житель выбрал (распределение выбора), что он съел (потребление и отходы с тарелки), как он оценивает питание (удовлетворённость) и в какой обстановке происходит приём пищи (среда). Учреждение, которое измеряет только первое, знает, что популярно, но не знает, что съедено; учреждение, которое измеряет только удовлетворённость, не увидит, если жители довольны, но недоедают.

Отходы с тарелки. Это наиболее изученный показатель. В обзоре Roulston и соавт. из 14 источников, измерявших отходы с тарелки в учреждениях длительного ухода, 10 использовали взвешивание и 6 — визуальную оценку [76]. Взвешивание точнее, но требует весов на этаже, маркировки подносов и времени персонала; визуальная оценка быстрее, но зависит от наблюдателя. В одной из включённых в обзор работ (Hansen и Derdowski, 2020) визуальная оценка проводилась по парным фотографиям тарелки до и после еды, и уже сам цвет посуды был связан с разной долей несъеденного: от 26 % на белой тарелке до 9 % на белой тарелке с жёлтым ободком и красным кольцом [76]. Этот результат приводится не как рекомендация покупать цветную посуду, а как напоминание: при сравнении «до» и «после» внедрения выбора посуда, порция и способ подачи должны оставаться прежними, иначе изменение отходов нельзя приписать выбору.

Обзор больничных вмешательств, направленных на снижение отходов с тарелки (Manimaran и соавт., 2023), включил девять исследований и разделил вмешательства на пять групп: изменение меню, обслуживание по заказу (room service), оформление меню, система подачи и инструменты мониторинга питания [92]. Вариативное меню затрагивает сразу три из этих групп, поэтому эффект его внедрения нельзя отделить от сопутствующих изменений подачи без специального дизайна.

Производственные отходы. Это масса блюд, приготовленных, но не розданных. В исследовании Wheeler и соавт. именно этот показатель вырос при переходе к выбору в момент еды (с 55 до 90 г на жителя в день) [61]. Для российского учреждения он измеряется проще всего: остаток каждого варианта взвешивается при списании, а

сама запись сочетается с требованием п. 32 СанПиН 4282-26 о запрете реализации остатков на следующий день [3]. Без этого показателя невозможно отличить «вариант Б непопулярен» от «вариант Б готовится в избытке».

Удовлетворённость. Для домов престарелых разработаны специальные опросники. Пересмотренный опросник Food Expectations — Long-Term Care (FoodEx-LTC) содержит 28 вопросов в пяти доменах; при первичной проверке на 61 жителе коэффициент α по доменам составил 0,65–0,82, ретестовая надёжность — 0,79–0,88 [93]. Wright и соавт. использовали Resident Foodservice Satisfaction Questionnaire и показали, что время между выбором и подачей влияет на удовлетворённость сильнее, чем характеристики самой еды [63]. Wheeler и соавт. обошлись пятибалльной шкалой Лайкерта [61]. Для российского учреждения, где значительная часть жителей не может заполнить многостраничную анкету, реалистичны короткая шкала по нескольким вопросам, которую заполняет сам житель или сотрудник со слов жителя, и структурированное наблюдение за теми, кто не может ответить (рекомендация). Успенский интернат перед внедрением провёл опрос и анкетирование и расставил блюда «по балльной системе в зависимости от степени спроса» [7] — пример упрощённого инструмента изучения предпочтений; сама анкета и её результаты не опубликованы. Отметим, что изучение спроса до запуска и оценка удовлетворённости после него — разные задачи, и вторая в российских сообщениях не описана.

Среда приёма пищи. Канадская группа M3 разработала протокол наблюдения Mealtime Scan, который заполняет обученный наблюдатель по ходу приёма пищи. Во вторичном анализе данных M3 (32 дома, 82 отделения, наблюдение 4–6 приёмов пищи в каждом отделении) большее число сотрудников в зале было связано с более ориентированными на отношения практиками в общих отделениях, но не в отделениях для людей с деменцией; авторы предполагают, что там решающую роль играет подготовка персонала [94]. Программа CHOICE+ с внешним сопровождением в течение 12 месяцев в трёх домах, оценённая по расширенной версии протокола (Mealtime Scan+; пять приёмов пищи каждые четыре месяца), дала статистически значимое улучшение физической и социальной среды и общего качества приёма пищи во всех трёх домах [95]. Для российского ДСО из этих работ следует простой вывод: изменения среды приёма пищи поддаются наблюдению по чек-листу, и его можно вести силами учреждения, если наблюдатель не участвует в раздаче (рекомендация).

Минимальный набор для учреждения (рекомендация автора, не норма):

Показатель	Метод	Периодичность	Кто ведёт
Распределение выбора	Журнал заказа или учёт розданных порций по вариантам	Ежедневно	Пищеблок или отделение
Производственные отходы	Взвешивание нерозданного остатка каждого варианта	Ежедневно	Пищеблок
Отходы с тарелки	Визуальная оценка по пятиуровневой шкале или взвешивание по выборке	7 дней до и 7 дней через месяц после изменения	Обученный сотрудник, не участвующий в раздаче

Показатель	Метод	Периодичность	Кто ведёт
Удовлетворённость	Короткий опрос (3–5 вопросов) со слов жителя	До запуска и ежеквартально	Специалист по социальной работе
Масса тела	По медицинской документации	В порядке, установленном врачом	Медицинская служба
Среда приёма пищи	Чек-лист наблюдения	Ежемесячно	Наблюдатель вне смены раздачи

Масса тела включена как показатель, который учреждение уже ведёт; её интерпретация — компетенция врача. Показатели не составляют научного исследования: без контрольной группы и при малой выборке они показывают направление изменений и позволяют заметить вред, но не доказывают эффект выбора.

8 Контроль: кто и что проверяет

8.1 Различие предметов контроля

Вариативное меню затрагивает предметы нескольких контролирующих органов, и каждый из них оценивает своё. Смешение предметов — источник большинства конфликтов при проверках: учреждение отвечает санитарному инспектору на вопрос о качестве социальной услуги или ведомственному контролёру — о санитарных нормах.

8.2 Санитарно-эпидемиологический надзор

Предмет — соблюдение обязательных требований СанПиН 4282-26 и других санитарных правил: приём продукции, условия хранения, поточность, температуры, сроки раздачи, бракераж, суточные пробы, медицинские осмотры персонала [3]. СанПиН прямо указывает, что оценка соблюдения содержащихся в нём рекомендательных норм не может быть предметом федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (п. 3) [3]. Число блюд на выбор, набор блюд и сам факт выбора предметом санитарного надзора не являются; каждое блюдо, однако, проверяется по общим правилам (сценарий 5). Ответственность — ст. 6.6 КоАП (п. 2.11).

8.3 Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания

Органы субъектов осуществляют региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания (ст. 33 442-ФЗ) [18]. Предмет — соблюдение требований к предоставлению социальных услуг, в том числе порядков, стандартов и норм питания, утверждённых субъектом. Именно здесь возникает вопрос о выполнении норм по группам продуктов (сценарий 1) и о соответствии фактического питания индивидуальной программе. Для вариативного меню существенно, что региональные нормы устанавливают количества, а не блюда; проверяющий вправе спросить, выполнены ли количества, но не вправе требовать единого меню, если такого требования нет в региональном акте (толкование). С 01.09.2025 к предмету этого контроля относится и исполнение обязанностей по Правилам, утверждённым приказом № 305н, в том числе обязанности обеспечивать условия для соблюдения постов (подп. 15 п. 20) [21]: проверяющий вправе спросить, как житель, соблюдающий пост, получает питание, и учреждение без вариативного или индивидуального постного варианта должно показать иной способ (толкование).

8.4 Учредитель

Учредитель государственного учреждения контролирует выполнение государственного задания и финансово-хозяйственную деятельность. Вариативное меню затрагивает его компетенцию постольку, поскольку меняются структура расходов на пита-

ние, штат или оборудование. Петербургское сообщение о вариативном меню прозвучало на заседании рабочей группы при Комитете по социальной политике [15]; этот формат — информирование учредителя и обсуждение с ним — снижает риск, что практика будет воспринята как самовольное отступление от порядка.

8.5 Прокуратура

Прокуратура проверяет соблюдение законов, в том числе прав проживающих, и применяет меры прокурорского реагирования, включая возбуждение дел об административных правонарушениях; примером служит дело по ст. 6.6 КоАП в отношении социально-реабилитационного центра в Кашине [47]. Для вариативного меню прокурорский контроль может работать в обе стороны: проверить качество питания и проверить, соблюдаются ли права жителей, предусмотренные ст. 9 442-ФЗ и (для ПНИ) ст. 37 Закона № 3185-1.

8.6 Антимонопольный контроль

ФАС России и территориальные органы контролируют закупки и выявляют картели на торгах продуктами (п. 2.11) [49, 50]. Для вариативного меню существует риск, что спецификация, составленная под конкретный вариант блюда, будет оценена как ограничивающая конкуренцию.

8.7 Независимая оценка и общественный контроль

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится по ст. 23.1 442-ФЗ, общественный контроль — по ст. 34 442-ФЗ [18]. Эти механизмы не порождают санкций, но формируют публичную репутацию учреждения. Для вариативного меню они служат каналом обратной связи от жителей и семей. Уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка в субъектах рассматривают жалобы и готовят доклады; в докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 г. описан пилотный проект «Вариативное меню» в образовательных организациях [54], а не в организациях социального обслуживания взрослых (п. 3.2).

8.8 Внутренний контроль

Внутренний контроль учреждения — бракеражная комиссия, совет (комиссия) по питанию, производственный контроль на основе принципов ХАССП (п. 4 СанПиН 4282-26) [3] — единственный уровень, который видит вариативное меню каждый день. Опыт Усть-Илимска и «Доброго дома „Солнечногорский“» показывает, что коллегияльный орган по питанию берёт на себя пересмотр меню, рассмотрение пожеланий и привлечение внешнего специалиста [10, 23]. Рабочая база проекта выделяет признаки «фиктивной вариативности» — разрыва между документом и фактической раздачей: журнал выбора заполнен одной рукой за неделю; более 90 % «стандартных» выборов; жители не помнят, что выбирали; второй вариант «закончился»

без записи о срыве; выбор только каши при заявленной полной вариативности [17]. Это рекомендательный чек-лист внутреннего контроля, а не критерий какого-либо надзорного органа.

8.9 Сводка

Контролёр	Предмет	Что спросит о вариативном меню	Основание
Роспотребнадзор	Обязательные санитарные требования	ТТК, бракераж, пробы, сроки раздачи каждого варианта	СанПиН 4282-26; ст. 6.6 КоАП
Региональный контроль соцобслуживания	Порядки, стандарты, нормы субъекта	Выполнение норм по группам продуктов; учёт замен; условия для соблюдения постов	Ст. 33 442-ФЗ; региональные нормы; приказ № 305н
Учредитель	Госзадание, финансы	Расходы, штат, оборудование	Устав, госзадание
Прокуратура	Законность, права жителей	Качество питания; права на выбор и уважение	Закон о прокуратуре; 442-ФЗ; 3185-1
ФАС	Конкуренция на торгах	Спецификации, картели	44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ
Независимая оценка, общественный контроль	Качество условий	Удовлетворённость	Ст. 23.1, 34 442-ФЗ
Внутренний контроль	Всё перечисленное, ежедневно	Реальность выбора	Локальные акты; п. 4 СанПиН 4282-26

9 Противоречия и нерешённые вопросы

9.1 Принцип

Материалы семинара 2026 г. — первая редакция обзора, доклад «Не просто накормить», предшествующие аналитические записки и рабочая база знаний проекта — создавались в разное время, разными методами и при разном доступе к источникам. Расхождения между ними неизбежны. Ниже они перечислены без сглаживания: для каждого указано, в чём расхождение, как оно разрешается по первоисточнику и что остаётся открытым. Номера в скобках — пункты перечня противоречий рабочей базы знаний [17], где он есть.

9.2 Перечень

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
1	Нормы взаимозаменяемости к постановлению № 12: «приложение 6» (первая редакция [1]) против «приложение 7»	В действующей редакции — приложение № 7; кроме того, есть приложение № 8 «Замена продуктов по белку и углеводам» [25]	Снято
2	Таблица замен приложения № 11 к СанПиН как основание для взрослых (первая редакция, канон, отраслевые материалы)	Нормативно таблица относится к питанию детей (подп. 4 п. 59 СанПиН 4282-26; п. 8.1.4 СанПиН 3590-20) [2, 3]; для взрослых — аналогия	Снято как норма, остаётся как рекомендация
3	Приказ № 520н отсутствует в первой редакции; федеральный блок построен на постановлении № 12 [1]	Действующие рекомендуемые нормы — приказ № 520н [26]; № 12 не отменено	Снято
4	СанПиН 3590-20 «действует до 01.01.2027» (первая редакция [1]) (7)	Утратил силу с 01.09.2026 в связи с введением СанПиН 4282-26 [3]; первоначальный срок действия действительно был установлен до 01.01.2027	Снято
5	Ст. 6.3 КоАП (первая редакция) против ст. 6.6 КоАП (канон) (15)	Общая и специальная нормы; для организации питания — ст. 6.6 [46]	Снято
6	Плата не более 75 %: ч. 4 ст. 32 442-ФЗ (канон) против п. 35 приказа № 935н (первая редакция) (14)	Обе ссылки верны: норма закона воспроизведена в примерном порядке [18, 19]	Снято

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
7	Приказ «№ 774н» как акт о нормах питания (академический слой) (13)	По открытым источникам не подтверждён	Не используется
8	Болотнинский ПНИ: модель 1 и модель 4 одновременно в первой редакции (10)	По тексту сообщения — М1 по шкале раздачи; деталь «выбор накануне» в источнике отсутствует [5]	Снято для v2
9	«Без существенного роста затрат» против «объективно дороже» в первой редакции (17)	Ни одно утверждение не основано на расчётах; зарубежные данные — рост на 9–20 % [61]; петербургский кейс называет оборудование и сотрудников [15]	Открыто: нужны российские данные
10	Пилот «Вариативное меню» в Санкт-Петербурге как пример практики ДСО (первая редакция) (20)	Пилот относится к образовательным организациям [54]	Снято
11	«Практика стран СНГ» без источников (первая редакция)	Источников не найдено	Исключено
12	Закон № 3185-1 отсутствует в первой редакции (16)	Для ПНИ применяются ст. 37 и 43 [20]	Снято
13	Hugo и соавт.: 8 австралийских долларов как стоимость «сырья» (канон [16])	8,00 — весь кейтеринг; сырьё — 6,08 [82]	Снято
14	Нормы СПб для ПНИ: одна норма с СБКС (первая редакция)	В постановлении № 1284 две нормы для ПНИ — с СБКС и без неё [27]	Снято
15	Суточная проба на собственном пищеблоке организации социального обслуживания	Подп. 4 п. 56 СанПиН 4282-26 говорит о медицинских организациях, подп. 12 — о готовых блюдах от сторонней организации [3]; для собственного пищеблока прямой нормы нет	Открыто; рекомендация — отбирать
16	«Субсидия на госзадание нередко остаётся в 44-ФЗ» для автономного учреждения (рабочая база)	По ч. 4 ст. 15 44-ФЗ автономное учреждение применяет 44-ФЗ при закупках за счёт субсидий на капитальные вложения, а не на госзадание [41]	Уточнено; применение к конкретному учреждению — вопрос его положения о закупке

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
17	Иерархия каналов воли: биография первой (канон, гл. 15.4) против текущего предпочтения первым (гл. 15.9) (2)	Первоисточник права не даёт ответа	Открыто; решение автора
18	«Принудительное кормление запрещено» (канон) против «прямого запрета не найдено» (аудиторский слой) (9)	Прямого запрета в проверенных актах не найдено; ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1 гарантирует гуманное отношение, исключающее унижение достоинства [20]	Открыто; требует правовой экспертизы
19	Календарь пилота: 90 дней (канон) против 12–24 месяцев (предшествующая записка)	Разные задачи — пилот и перестройка	Не противоречие
20	Определение вариативности: в момент еды (канон) / на приём или заказ заранее (первая редакция) / на период (предшествующая записка) (6)	Определения разных слоёв; v2 использует каноническое как рабочее, остальные описывает	Не сводится
21	Успенский ПНИ: «М2, шведской линии нет» (рабочая база)	Верно для сообщения 2024 г. [7]; в 2025 г. — «Шведский стол» в части отделений [8]	Снято с указанием дат
22	Усть-Илимский ДСО отнесён к ПНИ (рабочая база)	По сообщениям — бывший дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» [10]	Снято
23	Распоряжение Московской области № 19РВ-32 как медицинский «мостик» к лечебному питанию (рабочая база)	По сайту учреждения — нормы питания в ПНИ; ссылка на приказ № 330 относится к совету по питанию [23]	Снято
24	Нормы питания Москвы: приказ ДТСЗН № 228 (первая редакция) против постановления № 1068-ПП (библиография канона)	Акты в ходе подготовки v2 не сверялись	Открыто
25	Псковская область: приказ Комитета № 206 (первая редакция) против «постановления администрации № 206» (библиография канона)	Реквизиты по первой редакции и международной базе FAOLEX — приказ [58]	Вероятно снято; требует сверки
26	Иркутская область: «два первых, два вторых, гарниры» в регионе	Только пересказ агрегатора; первоисточник министерства не найден [11]	Открыто

№	Расхождение	Разрешение по первоисточнику	Статус
27	Объём первой редакции: 82 с. (PDF) против «83 страницы» (презентация) (18)	Техническое расхождение	Не влияет на содержание
28	Федеральная основа права на пост: только ст. 37, 43 Закона № 3185-1 для ПНИ (материалы семинара, первая редакция обзора)	С 01.09.2025 подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н обязывает все организации социального обслуживания обеспечивать условия для соблюдения постов [21]; приказ в материалах семинара не упоминался	Снято: пробел восполнен
29	Самообслуживание («шведский стол» в Успенском ПНИ, линия самообслуживания в «Солнечногорском») против санитарного контура раздачи	СанПиН 4282-26 специальных требований к самообслуживанию в организациях социального обслуживания не содержит (поиск по тексту); общие требования п. 32 — предел трёх часов для блюд, требующих разогревания, запрет реализации остатков на следующий день — применяются к блюдам на линии [3]. Сообщения учреждений не описывают, как эти требования выполняются [8, 23]	Открыто: нарушение не установлено, но и соблюдение не показано
30	Какой санитарный акт применим: СП 2.4.3648-20 (предшествующая записка), СанПиН 2.1.3684-21 (академический слой), СанПиН 3590-20 «до 01.01.2027» и СанПиН 1.2.3685-21 (первая редакция) (7)	СП 2.4.3648-20 регулирует организации для детей и молодёжи; СанПиН 2.1.3684-21 (содержание территорий, водоснабжение, помещения) и СанПиН 1.2.3685-21 (гигиенические нормативы факторов среды) к организации питания относятся косвенно. Организацию питания регулировал СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026) и регулирует СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026) [2, 3]	Снято: в докладе указан слой времени для каждой ссылки

9.3 Что из этого следует для читателя

Пункты 1–6, 10, 12–14, 21–23, 28 и 30 — исправления фактов или восполненные пробелы; во второй редакции применены исправленные версии. Пункты 9, 15, 17, 18, 24, 26 и 29 — открытые вопросы, по которым доклад не делает утверждений сверх установленного. Пункты 19 и 20 отражают разные задачи и разные определения и не требуют выбора одного варианта.

10 Предложения

Все предложения этого раздела — рекомендации автора как директора учреждения и участника профессиональной дискуссии. Они не выражают позицию Минтруда России, рабочей группы или иного органа и не являются нормами.

10.1 Федеральный уровень

1. **Определение.** В методическом документе федерального уровня (без изменения закона) закрепить рабочее определение вариативного питания и разграничить его с цикличным меню, таблицей замен и персонализацией (п. 1.2). Отсутствие общего словаря — главная причина, по которой одна и та же практика оценивается проверяющими по-разному.
2. **Таблица замен для взрослых.** Утвердить таблицу замен пищевой продукции для взрослых в организациях социального обслуживания или прямо распространить на них приложение № 11 к СанПиН 4282-26. Сейчас учреждения применяют детскую таблицу по аналогии (п. 2.6).
3. **Учёт норм по периоду.** Разъяснить, что выполнение норм питания в организациях социального обслуживания оценивается по среднему за период с учётом замен по утверждённой таблице, по образцу подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26 для детей [3].
4. **Суточная проба.** Устранить пробел о суточной пробе на собственном пищеблоке организации социального обслуживания (п. 9, позиция 15).
5. **Формула альтернативы.** При возможном регулировании выбора опираться не на число блюд, а на формулу «альтернатива сходной пищевой ценности по запросу», известную по американскому праву [85], и на онтарийскую модель цикла меню с выбором, утверждаемого диетологом при участии совета жителей [86]. Предложение первой редакции обзора закрепить «не менее двух вариантов на основные приёмы пищи» [1] реализуемо не во всех учреждениях и не решает проблему жителей, не способных выбрать вербально.
6. **Постное питание.** Разъяснить, как обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов (подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н) [21] исполняется в пределах региональных норм питания: какие замены мяса и молочных продуктов допустимы и по какой таблице. Без такого разъяснения учреждение исполняет федеральную обязанность с риском претензии регионального контроля за невыполнение норм по отдельным группам продуктов (п. 2.4, п. 2.6).
7. **Показатели результата.** В методических материалах о вариативном питании предусматривать не только описание формата, но и минимальный набор измеряемых показателей — распределение выбора, производственные отходы, отходы с тарелки, удовлетворённость (п. 7.12). Зарубежный опыт показывает, что такие показатели измеримы силами учреждения [61, 76].

10.2 Региональный уровень

1. **Нормы группами.** При пересмотре региональных норм формулировать позиции группами продуктов с допустимыми заменами внутри группы и указывать источник таблицы замен между группами (п. 3.11).
2. **Тариф.** При расчёте тарифа на обеспечение питанием учитывать не только продуктовый набор, но и организационную составляющую выбора, если субъект поддерживает вариативное питание как политику (п. 3.2).
3. **Методическая площадка.** Использовать опыт межрегиональных методических площадок (Вологодская область, 2026 г. [14]) и требовать от участников публикации измерений (отходы, распределение выбора, удовлетворённость), а не только описаний.

10.3 Уровень учреждения

1. **Начинать с пары внутри группы** в одном приёме пищи одного отделения (сценарии 2 и 9).
2. **Закрепить порядок локальным актом** до начала и подготовить комплект документов для проверяющего (сценарий 7).
3. **Измерять до и после** хотя бы отходы с тарелки и распределение выбора (сценарий 8, п. 7.12).
4. **Включать неговорящих и маломобильных** с первого этапа, а не после «отладки на ходячих» (сценарии 4 и 10).
5. **Публиковать результаты** с датами и числами, включая неудачи. Пока российские сообщения состоят из описаний без измерений (п. 4.10), спор о пользе и вреде выбора будет вестись аргументами мнения.

11 Заключение

Исследование позволяет сформулировать девять выводов. Класс каждого утверждения указан в соответствующем разделе; здесь выводы сведены без повторения ссылок там, где они уже приведены в тексте.

- 1. Право не предписывает и не запрещает выбор блюд.** Закон № 442-ФЗ требует обеспечивать питание по нормам, утверждённым субъектом Российской Федерации, и закрепляет за получателем право на уважительное и гуманное отношение и на участие в составлении индивидуальной программы (ст. 9) [18]. Ни приказ № 935н, ни приказ № 520н, ни Правила организации деятельности организаций социального обслуживания (приказ № 305н), ни санитарные правила не устанавливают числа блюд на выбор [2, 3, 19, 21, 26, 31]. Для жителей ПНИ к этому добавляются гарантии Закона № 3185-1, включая право соблюдать религиозные каноны (ч. 2 ст. 37 в силу ст. 43) [20], а с 01.09.2025 обязанность обеспечивать условия для соблюдения постов возложена на все организации социального обслуживания (подп. 15 п. 20 Правил по приказу № 305н) [21]. Постный вариант блюда в пост поэтому относится к исполнению обязанности, а не к инициативе кухни.
- 2. Смена санитарных правил не изменила ответа на вопрос о выборе, но изменила его цену.** С 01.09.2026 действует СанПиН 4282-26; СанПиН 3590-20 применяется к документам и событиям до 31.08.2026 [2, 3]. Новый акт, как и прежний, молчит о числе вариантов, но через требования к технологическому документу на каждое блюдо (п. 11), к трёхчасовому пределу на раздаче и запрету реализации остатков на следующий день (п. 32) и к бракеражу каждого блюда (подп. 13 п. 56) делает каждый дополнительный вариант отдельным объектом производственного контроля.
- 3. Главный правовой пробел — механизм эквивалентной замены для взрослых.** Таблица замен СанПиН (приложение № 11) адресована разделу о питании детей; для взрослых в социальном обслуживании её применяют по аналогии, а единственный федеральный документ о замене, адресованный этим учреждениям, — приложение № 7 к рекомендациям 2002 г. — носит рекомендательный характер. Постановление Санкт-Петербурга № 1284 положений о замене не содержит. Поэтому выбор между мясом и рыбой юридически уязвимее выбора между гречкой и рисом, хотя обе пары могут быть эквивалентны по пищевой ценности.
- 4. Региональные нормы дают выбору больше простора, чем принято считать.** Нормы № 1284 сформулированы по группам продуктов; внутри группы (крупы, овощи, мясо разных видов) учреждение вправе составлять пары блюд без обращения к таблице замен. Выполнение нормы по среднему за период прямо закреплено только для детей (подп. «в» подп. 2 п. 59 СанПиН 4282-26); для взрослых это толкование, требующее закрепления в локальном акте.
- 5. Российская практика выросла, но не измерена.** За 2024–2026 гг. найдены сообщения восьми учреждений и одного регионального органа: от выбора в момент еды из двух вторых блюд (Болотнинский, Каменский, Успенский, Усть-

Илимский) до самообслуживания («шведский стол» в Успенском, линия раздачи в Солнечногорском) и заказа на кануне (Серафимовский). С июня 2026 г. в Вологодской области работает межрегиональная площадка. Ни одно учреждение не опубликовало данных о потреблении, отходах или стоимости. Сообщения учреждений — самоотчёты, а не результаты проверки.

6. **Научные данные не подтверждают главного опасения.** В исследованиях домов престарелых выбор связан с более высокой удовлетворённостью; в работе Wheeler и соавт., где сопоставлен состав съеденного при старой и новой системе, блюда из меню с выбором содержали чуть больше белковых продуктов и овощей [61]. Те же данные показывают цену выбора в момент еды: рост производственных отходов и стоимости примерно на 9–20 % [61]. Систематические обзоры оценивают эффект вмешательств в организацию питания на пищевой статус как небольшой и плохо измеренный [69, 70]. Исследований вариативного меню в психиатрических учреждениях длительного пребывания нет; опасение, что жители ПНИ будут систематически выбирать «вредное», опирается на данные о потреблении вне учреждений [71] и в условиях нормированного набора не проверено.
7. **Зарубежное право регулирует не число блюд, а альтернативу и участие.** Регламент CQC в Англии требует учитывать предпочтения, федеральные требования США — предлагать альтернативу сходной пищевой ценности, регламент Онтарио — цикл меню с выбором, согласованный с советом жителей [83, 85, 86]. Ни один из изученных актов не устанавливает минимального числа вторых блюд. Перенос этих формул в российское право возможен только через акт федерального или регионального уровня.
8. **Выбор, недоступный жителю, не является выбором.** И австралийские данные о низком выборе для получающих протёртую пищу [64], и канадские данные о том, что пища изменённой консистенции назначена 47 % жителей [78], показывают: вариативное меню, рассчитанное на ходячих и говорящих, может не дойти до значительной части дома. Включение маломобильных и невербальных жителей — условие, а не следующий этап.
9. **Противоречия не устранены, а названы.** Глава 9 перечисляет 30 расхождений между нормами, толкованиями, кейсами и предшествующими материалами семинара, включая исправленные в этой редакции фактические ошибки. Часть из них может быть снята только решением органа, уполномоченного на разъяснение или нормотворчество.

Практический итог для руководителя учреждения сводится к трём требованиям, основанным в главе 7: закрепить порядок вариативного питания и источник таблицы замен локальным актом до начала; обеспечить каждый вариант технологическим документом, бракеражем и пробой; измерять результат — хотя бы распределение выбора и отходы с тарелки — до и после изменений. Предложения главы 10 являются рекомендациями автора и не выражают позицию какого-либо органа.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Пометка [н] — источник, впервые привлечённый во второй редакции; [о] — источник, использованный и в первой редакции [1].

1. [о] Вариативное меню: НПА. Нормативно-правовое регулирование и региональная практика: доклад (литературная редакция 29.08.2026). 82 с. — Репозиторий qololp/seminar-variable-food-2026, папка raw/sources/variativnoe-menu-npa-2026/.
2. [о] СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; утратил силу с 01.09.2026). — URL: <https://base.garant.ru/74891586/> (дата обращения: 05.10.2026).
3. [н] СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18; зарег. в Минюсте России 02.06.2026 № 86854; действует с 01.09.2026 до 01.09.2032). — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/414229257/> (дата обращения: 05.10.2026).
4. [н] Как устроены ПНИ в России: исследование / Проект «Если быть точным». 09.04.2026. — URL: <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym> (дата обращения: 23.07.2026).
5. [о] Вариативное питание / ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». 16.08.2024. — URL: <https://bpni.nso.ru/news/2312> (дата обращения: 05.10.2026).
6. [н] Вариативное питание — выбор за вами! / ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат». 03.09.2026. — URL: <https://bpni.nso.ru/news/8993> (дата обращения: 05.10.2026).
7. [н] Наше стремление — сделать питание не только вкусным и разнообразным, но и комфортным... / ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат». 13.08.2024. — URL: <https://upni.nso.ru/news/1916> (дата обращения: 05.10.2026).
8. [н] Разумная Т. Успенский интернат расширяет «Шведский стол»: теперь и в третьем отделении проживающие сами выбирают блюда // ЧС-ИНФО. 23.10.2025. — URL: <https://4s-info.ru/2025/10/23/uspenskij-internat-rasshiryayet-shvedskij-stol-teper-i-v-tretem-otdelenii-prozhivayushhie-sami-vybirayut-blyuda/> (дата обращения: 05.10.2026).
9. [н] Вариативное питание означает наличие нескольких вариантов меню в столовой / ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат». 19.08.2024. — URL: <https://kpi.nso.ru/news/395> (дата обращения: 05.10.2026).
10. [н] ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания». Публикации: «Что за „зверь“ такой? Вариативное питание» (27.09.2024); «Четыре месяца — время анализов и результатов» (17.12.2024); «Что у Вас сегодня на ужин?» (13.02.2025); «Совет по питанию» (09.02.2026). — URL: <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (дата обращения: 05.10.2026).

11. [н] Вариативное питание в стационарных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (пересказ сообщения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) // Безформата. 14.02.2025. — URL: <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (дата обращения: 23.07.2026; при повторном обращении 05.10.2026 доступ ограничен).
12. [н] В Чунском доме соцобслуживания завершается строительство двух модульных жилых корпусов / Пресс-служба Правительства Иркутской области // Областная газета. 26.11.2025. — URL: <https://www.ogirk.ru/2025/11/26/v-chunskom-zavershaetsja-stroitelstvo-dvuh-modulnyh-zhilyh-korpusov/> (дата обращения: 05.10.2026).
13. [н] Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014 № 193-мпр «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/34763286/> (дата обращения: 05.10.2026).
14. [н] Вариативное меню появляется в домах соцобслуживания Вологодчины // СеверИнфо. 05.07.2026. — URL: <https://www.severinfo.ru/society/91519-variativnoe-menju-pojavljaetsja-v-domah-socobszluzhivanija-vologodchiny.html> (дата обращения: 05.10.2026).
15. [н] Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается / Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 22.07.2025. — URL: <https://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (дата обращения: 05.10.2026).
16. [н] Не просто накормить: доклад к семинару 25–27.08.2026. — Репозиторий [qlolp/seminar-variable-food-2026](#), папка [raw/sources/ne-prosto-nakormit/doklad/](#).
17. [н] Рабочая база знаний проекта (wiki/, в том числе [wiki/gaps.md](#), [wiki/entities/](#), [wiki/concepts/](#)) и предшествующие аналитические записки ([raw/sources/related/](#)). — Репозиторий [qlolp/seminar-variable-food-2026](#).
18. [о] Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 05.10.2026).
19. [о] Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/70829256/> (дата обращения: 05.10.2026).
20. [н] Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 05.10.2026).
21. [н] Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (зарег. в Минюсте России 02.06.2025 № 82485; действует с 01.09.2025 до 01.09.2031). — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_506945/ (дата обращения: 05.10.2026).
22. [н] Правила внутреннего распорядка СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» (утв. приказом от 10.03.2026 № 124). Архивная копия сайта учреждения от

- 15.04.2026. — URL: <https://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/> (дата обращения: 21.08.2026).
23. [н] Питание / ГАСУСО МО «Добрый дом „Солнечногорский“». — URL: <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (дата обращения: 05.10.2026).
24. [н] Nijs K. A. N. D., de Graaf C., Kok F. J., van Staveren W. A. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial // *BMJ*. 2006. Vol. 332. P. 1180–1184. DOI: 10.1136/bmj.38825.401181.7C.
25. [о] Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 04.06.2007 № 397). — URL: <https://base.garant.ru/184396/>; первоначальная редакция: <https://base.garant.ru/5365902/> (дата обращения: 05.10.2026).
26. [н] Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания». — URL: <https://base.garant.ru/405707433/>; <https://mintrud.gov.ru/docs/2466> (дата обращения: 05.10.2026).
27. [о] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» (в ред. постановлений от 27.07.2017 № 616, от 19.12.2019 № 929, от 27.06.2022 № 561). — URL: <https://base.garant.ru/22921449/> (дата обращения: 05.10.2026).
28. [о] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.10.2026).
29. [н] Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006; ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ). — URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 05.10.2026).
30. [н] Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law. CRPD/C/GC/1. — URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/031/20/pdf/g1403120.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
31. [н] Агафонов И. Что изменится в жизни подопечных ПНИ с сентября // Милосердие.ru. 20.06.2025. — URL: <https://www.miloserdie.ru/news/novye-pravila-i-novye-vozmozhnosti-chto-izmenitsya-v-zhizni-podopechnyh-pni-s-sentyabrya/> (дата обращения: 05.10.2026).
32. [н] Постановление Минтруда России от 25.12.2003 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по организации диетического (лечебного) питания в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (реквизиты по справке к [15] в системе «Гарант»; текст не анализировался).

33. [н] Горелик С. Г. и др. Оценка нутритивного статуса и коррекция питания лиц пожилого возраста в учреждении социального обслуживания // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2020. № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 05.10.2026).
34. [н] МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» (утв. Роспотребнадзором 22.07.2021). — URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=18979 (дата обращения: 05.10.2026).
35. [о] Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП (нормы питания в организациях социального обслуживания). — URL: <https://base.garant.ru/405688359/> (дата обращения: 05.10.2026).
36. [о] Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». — URL: <https://base.garant.ru/12133007/> (дата обращения: 05.10.2026).
37. [о] Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания». — URL: <https://base.garant.ru/70412098/> (дата обращения: 05.10.2026).
38. [о] Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием». — URL: <https://base.garant.ru/74703746/> (дата обращения: 05.10.2026).
39. [н] Ткачёва О. Н., Тутельян В. А., Шестопалов А. Е. и др. Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста. Клинические рекомендации // Российский журнал гериатрической медицины. 2021. № 1. С. 15–34. DOI: 10.37586/2686-8636-1-2021-15-34.
40. [о] Организация питания: страницы сайтов учреждений социального обслуживания Омской области. — URL: <http://www.ditavrich55.ru/pitanie> ; <https://pni55.ru/perechen-zapreshchennyh-produktov> (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
41. [н] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 05.10.2026).
42. [н] Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 05.10.2026).
43. [н] Письмо Минфина России от 29.12.2014 № 02-02-08/68298. — URL: <https://base.garant.ru/70853116/> (дата обращения: 05.10.2026).
44. [н] Сообщение об определении Верховного Суда РФ от 28.01.2026 № 303-ЭС25-15393 (блог pro-ability.ru; первоисточник не проверен; в докладе не используется как установленный факт).
45. [н] Извещение № 0372200070825000244 «Поставка продуктов питания» (заказчик — СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“», ИНН 7827661874; опубл. 24.11.2025). — URL: <https://www.tenderguru.ru/tender/90473908> (дата обращения: 05.10.2026).

46. [о] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Ст. 6.3, 6.6, 6.7. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 05.10.2026).
47. [н] Новости прокуратуры: привлечение к ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ руководителя социально-реабилитационного центра (2022) // Кашин.инфо. — URL: <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (дата обращения: 23.07.2026).
48. [н] Постановление Верховного Суда РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (дата обращения: 05.10.2026).
49. [н] ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов // Российская газета. 25.07.2024. — URL: <https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html> (дата обращения: 23.07.2026).
50. [н] Челябинское УФАС: картель на 27 тендерах школьного питания // Про-Госзаказ. 2025. — URL: <https://pro-goszakaz.ru/news/116068> (дата обращения: 05.10.2026).
51. [н] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 929 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284». — URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/peterburg/1318583/> (дата обращения: 05.10.2026).
52. [н] Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге». — URL: <https://base.garant.ru/22921910/> (дата обращения: 05.10.2026).
53. [н] Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.12.2024 № 1366-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2025 год». — URL: <https://base.garant.ru/411120324/>; распоряжение от 15.12.2025 № 1155-р (тарифы на 2026 г.): <http://publication.pravo.gov.ru/document/7801202512190004> (дата обращения: 05.10.2026).
54. [о] Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге за 2024 год. — URL: https://spbdeti.org/upload/iblock/357/f10ncjwqspqic00z1kiskc8zw7jy26ow/ZAKS_2025.pdf (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
55. [о] Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.03.2021 № 228 «Об утверждении норм питания...». — URL: <https://base.garant.ru/405012407/> (дата обращения: 05.10.2026).
56. [о] Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области от 21.04.2022 № 214; постановление Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709 (по первой редакции обзора [79]). — URL: <https://base.garant.ru/404606671/> (дата обращения: 05.10.2026).
57. [о] Приказ от 11.11.2014 № 171-п (нормы питания в организациях социального обслуживания Омской области). — URL: <https://base.garant.ru/15588873/> (дата обращения: 05.10.2026).

58. [о] Приказ Комитета по социальной защите населения Псковской области от 14.07.2020 № 206 (нормы питания). — URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/rus203529.pdf> (дата обращения: 05.10.2026).
59. [н] Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (нормы питания), актуальная редакция; постановление Правительства Ленинградской области № 458; постановление Правительства ХМАО — Югры № 306-п (реквизиты — по докладу [80]; тексты не анализировались). — URL: https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (дата обращения: 23.07.2026).
60. [о] Отчёт о результатах контрольного мероприятия по организации питания в государственном автономном учреждении здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница» / Счётная палата Республики Татарстан. 2025. — URL: https://spst.tatar/files/Otchet_Psih_2025.pdf (дата обращения: 16.07.2026, по первой редакции обзора).
61. [н] Wheeler M., Abbey K. L., Capra S. M. Choice on the menu: Increasing meal choice for people living in residential aged care, a pilot study // *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. 2025. Vol. 38, № 1. e13401. DOI: 10.1111/jhn.13401.
62. [н] Cereda E., Pedrolli C., Klersy C. et al. Nutritional status in older persons according to healthcare setting: A systematic review and meta-analysis of prevalence data using MNA® // *Clinical Nutrition*. 2016. Vol. 35, № 6. P. 1282–1290. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.03.008.
63. [н] Wright O. R. L., Connelly L. B., Capra S., Hendrikz J. Determinants of foodservice satisfaction for patients in geriatrics/rehabilitation and residents in residential aged care // *Health Expectations*. 2013. Vol. 16, № 3. P. 251–265. DOI: 10.1111/j.1369-7625.2011.00711.x.
64. [н] Abbey K. L., Wright O. R. L., Capra S. Menu Planning in Residential Aged Care — The Level of Choice and Quality of Planning of Meals Available to Residents // *Nutrients*. 2015. Vol. 7, № 9. P. 7580–7592. DOI: 10.3390/nu7095354.
65. [н] Wheeler M., Abbey K. L., Capra S. M. Choice on the menu in residential aged care: An underrated tool for maintaining resident autonomy // *Nutrition & Dietetics*. 2025. Vol. 82, № 3. P. 327–336. DOI: 10.1111/1747-0080.70002.
66. [н] McCray S., Maunder K., Krikowa R., MacKenzie-Shalders K. Room Service Improves Nutritional Intake and Increases Patient Satisfaction While Decreasing Food Waste and Cost // *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2018. Vol. 118, № 2. P. 284–293. DOI: 10.1016/j.jand.2017.05.014.
67. [н] Crogan N. L., Dupler A. E., Short R., Heaton G. Food choice can improve nursing home resident meal service satisfaction and nutritional status // *Journal of Gerontological Nursing*. 2013. Vol. 39, № 5. P. 38–45. DOI: 10.3928/00989134-20130313-02.
68. [н] Divert C., Laghmaoui R., Crema C. et al. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal pleasure // *Appetite*. 2015. Vol. 84. P. 139–147. DOI: 10.1016/j.appet.2014.09.027.
69. [н] Abbott R. A., Whear R., Thompson-Coon J. et al. Effectiveness of mealtime interventions on nutritional outcomes for the elderly living in residential care: a

- systematic review and meta-analysis // *Ageing Research Reviews*. 2013. Vol. 12, № 4. P. 967–981. DOI: 10.1016/j.arr.2013.06.002.
70. [H] Herke M., Fink A., Langer G. et al. Environmental and behavioural modifications for improving food and fluid intake in people with dementia // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2018. № 7. CD011542. DOI: 10.1002/14651858.CD011542.pub2.
 71. [H] Teasdale S. B., Ward P. B., Samaras K. et al. Dietary intake of people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis // *British Journal of Psychiatry*. 2019. Vol. 214, № 5. P. 251–259. DOI: 10.1192/bjp.2019.20.
 72. [H] Özdemir A., Chapman H., Hall R., Ellahi B. Eating Well When Living With an Intellectual Disability — Exploring the Carer: Client Relationship in Residential Settings // *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*. 2025. Vol. 38, № 6. e70157. DOI: 10.1111/jar.70157.
 73. [H] Pfister F., Uhlmann K., Olalia L., Kaufmann B. Institutional and interpersonal determinants of dietary practices of persons with intellectual disability in institutional accommodation in Switzerland: a qualitative study // *BMC Public Health*. 2026. Vol. 26. Art. 1100. DOI: 10.1186/s12889-026-26794-7.
 74. [H] Volkert D., Beck A. M., Cederholm T. et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics // *Clinical Nutrition*. 2022. Vol. 41, № 4. P. 958–989. DOI: 10.1016/j.clnu.2022.01.024.
 75. [H] Volkert D., Beck A. M., Faxén-Irving G. et al. ESPEN guideline on nutrition and hydration in dementia — Update 2024 // *Clinical Nutrition*. 2024. Vol. 43, № 6. P. 1599–1626. DOI: 10.1016/j.clnu.2024.04.039.
 76. [H] Roulston M., Thompson C., Pelly F., Cave D. Food waste in residential aged care: A scoping review // *Nutrition & Dietetics*. 2026. Vol. 83, № 1. P. 56–73. DOI: 10.1111/1747-0080.70034.
 77. [H] Williams P., Walton K. Plate waste in hospitals and strategies for change // *e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism*. 2011. Vol. 6, № 6. P. e235–e241. DOI: 10.1016/j.eclnm.2011.09.006.
 78. [H] Vucea V., Keller H. H., Morrison J. M. et al. Prevalence and Characteristics Associated with Modified Texture Food Use in Long Term Care: An Analysis of Making the Most of Mealtimes (M3) Project // *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*. 2019. Vol. 80, № 3. P. 104–110. DOI: 10.3148/cjdpr-2018-045.
 79. [H] Porter J., Ottrey E., Huggins C. E. Protected Mealtimes in hospitals and nutritional intake: Systematic review and meta-analyses // *International Journal of Nursing Studies*. 2017. Vol. 65. P. 62–69. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2016.11.002.
 80. [H] Hamasaki Y., Sakata N., Jin X. et al. Facility staffing associated with potentially avoidable hospitalizations in nursing home residents in Japan: a retrospective cohort study // *BMC Geriatrics*. 2023. Vol. 23. Art. 566. DOI: 10.1186/s12877-023-04278-2.
 81. [H] Keller H. H., Syed S., Dakkak H. et al. Reimagining Nutrition Care and Mealtimes in Long-Term Care // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2022. Vol. 23, № 2. P. 253–260.e1. DOI: 10.1016/j.jamda.2021.12.021.
 82. [H] Hugo C., Isenring E., Sinclair D., Agarwal E. What does it cost to feed aged care residents in Australia? // *Nutrition & Dietetics*. 2018. Vol. 75, № 1. P. 6–10. DOI: 10.1111/1747-0080.12368.

83. [н] The Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014 (SI 2014/2936). Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs. — URL: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2936/regulation/14> (дата обращения: 05.10.2026).
84. [н] Scottish Government. Health and Social Care Standards: my support, my life. 2017. Standards 1.33–1.39; Care Inspectorate. Eating and drinking well in care: good practice guidance. — URL: <https://www.gov.scot/publications/health-social-care-standards-support-life/> ; <https://www.careinspectorate.com/> (дата обращения: 05.10.2026).
85. [н] 42 CFR § 483.60. Food and nutrition services. — URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60> (дата обращения: 05.10.2026).
86. [н] Ontario Regulation 246/22 (General) under the Fixing Long-Term Care Act, 2021. Section 77: Menu planning (воспроизведено по: OSNAC Menu Evaluation & Approval Tool for LTC, July 2022). — URL: <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246> ; https://www.osnac-fnat.com/_files/ugd/666b77_dd887e8092914e799e758624ed767e8e.pdf (дата обращения: 05.10.2026).
87. [н] Australian Government, Department of Health, Disability and Ageing. Strengthened Aged Care Quality Standards (Standard 6: Food and nutrition), в силе с 01.11.2025; Basic Daily Fee supplement. — URL: <https://www.health.gov.au/> (дата обращения: 05.10.2026).
88. [н] Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Senioreneinrichtungen. Bonn. — URL: <https://www.fitimalter-dge.de/> (дата обращения: 05.10.2026).
89. [н] Österreichische Gesellschaft für Ernährung / Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Qualitätsstandard für die Verpflegung in Pflegeeinrichtungen (2022). — URL: <https://www.sozialministerium.at/> (дата обращения: 05.10.2026).
90. [н] Livsmedelsverket. Bra måltider i äldreomsorgen. Uppsala. — URL: <https://www.livsmedelsverket.se/> (дата обращения: 05.10.2026).
91. [н] Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). Long-term care insurance: nutrition management; LIFE (Long-term care Information system For Evidence), 2021. — URL: <https://www.mhlw.go.jp/> (дата обращения: 05.10.2026).
92. [н] Manimaran S., Razalli N. H., Abdul Manaf Z. et al. Strategies to Reduce the Rate of Plate Waste in Hospitalized Patients: A Scoping Review // *Nutrients*. 2023. Vol. 15, № 2. Art. 301. DOI: 10.3390/nu15020301.
93. [н] Crogan N. L., Evans B. C. The shortened food expectations — long-term care questionnaire: assessing nursing home residents' satisfaction with food and food service // *Journal of Gerontological Nursing*. 2006. Vol. 32, № 11. P. 50–59. DOI: 10.3928/00989134-20061101-08.
94. [н] Trinca V., Chaudhury H., Slaughter S. E. et al. Making the Most of Mealtimes (M3): Association Between Relationship-Centered Care Practices, and Number of Staff and Residents at Mealtimes in Canadian Long-Term Care Homes // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2021. Vol. 22, № 9. P. 1927–1932.e1. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.11.020.

95. [н] Keller H. H., Wu S. A., Iraniparast M. et al. Relationship-Centered Mealtime Training Program Demonstrates Efficacy to Improve the Dining Environment in Long-Term Care // Journal of the American Medical Directors Association. 2021. Vol. 22, № 9. P. 1933–1938.e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.11.008.
96. [о] Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ (дата обращения: 05.10.2026).
97. [о] Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». — URL: <https://base.garant.ru/12117866/> (дата обращения: 05.10.2026).
98. [о] Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 05.10.2026).

Приложение А. Реестр нормативных и иных актов

Классы: Н — норма (обязательна); Р — рекомендация (рекомендательный акт); МР — методический документ; Л — локальная форма; И — иностранный акт (в России не действует). Статус — на 05.10.2026.

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
1	Конституция РФ, ст. 7, 21, 39, 41	Н	Социальное государство, достоинство, социальное обеспечение, охрана здоровья	[28]
2	Конвенция о правах инвалидов, ст. 19, 25, 28	Н (междунар.)	Самостоятельный образ жизни, здоровье, достаточный уровень жизни	[29]
3	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ	Н	Права получателей, индивидуальная программа, плата до 75 %	[18]
4	Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1, ст. 5, 37, 43	Н	Для ПНИ: гуманное отношение, религиозные каноны и пост	[20]
5	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ	Н	Основание санитарных правил	[96]
6	Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ	Н	Качество и безопасность пищевых продуктов; диетическое питание	[97]
7	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ	Н	Медицинская помощь, лечебное питание	[98]
8	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ч. 4 ст. 15, ч. 24 ст. 22, ст. 95	Н	Закупки бюджетных учреждений; цена единицы; изменение количества	[41]
9	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ	Н	Закупки автономных учреждений	[42]
10	КоАП РФ, ст. 6.3, 6.6	Н	Санитарная ответственность	[46]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
11	Приказ Минтруда России от 14.05.2025 № 305н (Правила организации деятельности), п. 15, подп. 10, 13, 15 п. 20, п. 29; прил. № 2	Н (прил. № 2 — Р)	Нормы питания — акт субъекта; условия для соблюдения постов во всех организациях; помещение для приготовления пищи получателями	[21]
12	Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н	Р (примерный порядок)	Питание как социально-бытовая услуга	[19]
13	Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н	Р	Рекомендуемые нормы питания	[26]
14	Постановление Минтруда России от 15.02.2002 № 12 (ред. 04.06.2007)	МР	Продуктовые наборы, меню-раскладки, нормы взаимозаменяемости (прил. 7), замена по белку и углеводам (прил. 8)	[25]
15	Постановление Минтруда России от 25.12.2003 № 90	МР	Диетическое (лечебное) питание в учреждениях соцобслуживания	[32]
16	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ от 27.10.2020 № 32)	Н, утратил силу с 01.09.2026	Применялся до 31.08.2026	[2]
17	СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ от 02.06.2026 № 18)	Н, с 01.09.2026 до 01.09.2032	Действующие санитарные требования; п. 3, 11, 24, 25, 32, 43, 56, 59	[3]
18	МР 2.3.1.0253-21	МР	Нормы физиологических потребностей	[34]
19	Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330	Н (для медорганизаций)	Лечебное питание; совет по питанию	[36]
20	Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н	Н (для медорганизаций)	Нормы лечебного питания	[37]
21	Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н	Н (для медорганизаций)	Порядок обеспечения лечебным питанием	[38]
22	Пост. Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 (ред. 27.06.2022 № 561)	Н	Нормы питания СПб; две нормы для ПНИ	[27]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
23	Пост. Правительства СПб от 29.12.2014 № 1283	Н	Порядки предоставления социальных услуг в СПб	[52]
24	Распоряжение КСП СПб от 13.12.2024 № 1366-р; от 15.12.2025 № 1155-р	Н	Тарифы на 2025 и 2026 гг.	[53]
25	Пост. Правительства СПб от 19.12.2019 № 929	Н	Новая редакция норм с 01.01.2020	[51]
26	Приказ ДТСЗН г. Москвы от 22.03.2021 № 228	Н	Нормы питания Москвы	[55]
27	Пост. Правительства Свердловской обл. от 10.11.2022 № 765-ПП	Н	Нормы питания; ссылка на прил. 11 СанПиН	[35]
28	Пост. Правительства Нижегородской обл. от 20.10.2014 № 709	Н	Нормы питания	[56]
29	Приказ Омской обл. от 11.11.2014 № 171-п	Н	Нормы питания	[57]
30	Приказ КСЗН Псковской обл. от 14.07.2020 № 206	Н	Нормы питания	[58]
31	Пост. Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п	Н	Нормы питания (не анализировалось)	[59]
32	Распоряжение минсоцразвития Московской обл. от 13.04.2017 № 19РВ-32	Н	Нормы питания в ПНИ Московской обл. (по [23])	[23]
33	Приказ минсоцразвития Иркутской обл. от 11.12.2014 № 193-мпр	Н	Порядок предоставления услуг в стационарной форме	[13]
34	Приказ СПб ГАСУ-СОН «ДСО „Серафимовский“» от 10.03.2026 № 124	Л	Правила внутреннего распорядка; заказное питание	[22]

№	Акт	Класс	Значение для вариативного меню	Источник
35	Health and Social Care Act 2008 (Regulated Activities) Regulations 2014, reg. 14	И	Предпочтения как часть потребности в питании	[83]
36	Health and Social Care Standards (Scotland), 2017	И	Право выбирать и участвовать в планировании меню	[84]
37	42 CFR § 483.60	И	Альтернатива сходной пищевой ценности; ≤14 ч	[85]
38	O. Reg. 246/22 (Ontario), s. 77	И	Цикл ≥21 дня с выбором на каждом приёме	[86]

Приложение Б. Нормы постановления № 1284: все столбцы для взрослых

Нетто, граммы на человека в сутки, если не указано иное [27]. Столбцы: (1) учреждения, кроме ПНИ; (2) ПНИ, норма с СБКС; (3) лица с сахарным диабетом; (4) лица с заболеваниями ЖКТ; (5) ПНИ, норма без СБКС; (6) рекомендуемая норма приказа № 520н для лиц 18 лет и старше [26].

Продукт	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 520н
Хлеб ржаной	150	150	250	150	200	150
Хлеб пшеничный	100	200	10	150	250	150
Мука пшеничная	45	45	17	40	45	15
Мука картофельная (крахмал)	2,5	3	—	3	3	5
Макаронные изделия	20	25	16	24	25	20
Крупы, бобовые	80	49,6	111	53	70	80
Овощи (все группы)	318	380	402	233,6	380	394,5 ¹
Картофель	168	268	44	126,2	268	200
Фрукты и ягоды свежие	200	100	385	200	100	150
Сухофрукты, шиповник	10	16	81	10	16	20 + 15 ²
Соки	60	60	66 ³	74	60	100 мл
Мясо (говядина, свинина)	90	70,5	55	57,8	85,2	90
Птица	40	36,5	40	42,7	35	22,2
Колбаса, колбасные изделия	25	25	21	21	25	12
Рыба, рыбопродукты	41,8	46,7	30,8	26,4	46,7	32,5
Сыр	14	9,3	6,5	12,1	9,3	15
Яйцо	4 шт./нед	4 шт./нед	3,5 шт./нед	4 шт./нед	4 шт./нед	½ шт./сут
Молоко	200	200	240	213	200	200 мл
Кисломолочные продукты	200	200	200	200	200	121 мл

Продукт	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 520н
Творог	40	50	80	42	50	20
Масло сли- вочное	20	20	23	24	23	20
Масло рас- тительное	20	20	21	14	23	20 мл
Маргарин	10	10	—	—	4	—
Сметана	10	15	24	17	15	15
Кондитер- ские изде- лия	15	15	—	14	15	50 ⁴
Сахар	57	57	15 ⁵	53	57	(в составе 50 ⁴)
Сахарозаме- нитель	—	—	4	—	—	—
Чай	2	2	2	2	2	2
Кофе, ко- фейный на- питок, какао	1,5	2	1	1,5	2	1,4
Соль	10	10	4	4	10	8
СБКС	27	27	—	—	—	27 по мед. показаниям
Витаминно- минераль- ные ком- плексы	1 драже 3 раза в неде- лю	1 драже 3 раза в неде- лю	—	—	1 драже 3 раза в неде- лю	50–100 % фи- зиол. нормы по мед. по- казаниям

¹ Сумма: свежие 340 + солёные и маринованные 15 + зелень 14,8 + консервированные 24,7. ² Сухофрукты 20 и шиповник 15 указаны в приказе № 520н отдельно. ³ Для лиц с сахарным диабетом — «сок без сахара». ⁴ В приказе № 520н — единая позиция «сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия». ⁵ Для лиц с сахарным диабетом сахар не входит в рецептуру блюд и выдаётся отдельно (примечание к постановлению № 1284).

Приложение В. Изменения по сравнению с первой редакцией

Раздел первой редакции	Что изменено во второй редакции	Основание
Введение	Добавлены классы утверждений и указание на действующую редакцию СанПиН	Переход на СанПиН 4282-26 с 01.09.2026 [3]
Понятийный аппарат	Разграничены цикличное меню, вариативное меню, таблица замен, персонализация; три шкалы (раздача, участие, модели обзора)	Рабочая база проекта [17]
Федеральный уровень	Добавлены приказ № 305н (Правила организации деятельности, с 01.09.2025), приказ № 520н, Закон № 3185-1, постановление № 90 (2003); исправлен номер приложения норм взаимозаменяемости (7 вместо 6), добавлено приложение № 8; ст. 6.6 КоАП как специальная норма	[20, 25, 26, 46]
Санитарные правила	СанПиН 3590-20 заменён на СанПиН 4282-26 с хронологией перехода; установлено, что таблица замен прил. 11 нормативно детская	[2, 3]
Региональный уровень	Петербургская норма проверена по тексту; выявлена вторая норма для ПНИ (без СБКС); добавлены тарифы 2025 г. и постановление № 1283; удалены неподтверждённые характеристики практик Москвы и Нижегородской области; пилот детского омбудсмена отнесён к школам	[27, 52–54]
Практика регионов	Вместо одного кейса — восемь учреждений и региональное сообщество; удалены детали, отсутствующие в источнике (выбор накануне в Болотнинском ПНИ)	[5–15, 22, 23]
Зарубежный опыт	Раздел о странах СНГ удалён как неподтверждённый; добавлены первоисточники Англии, Шотландии, США, Онтарио, Австралии, Германии, Швеции, Японии	[83–91]
Научная база	Добавлен раздел о научных данных (выбор, удовлетворённость, пищевой статус, отходы, стоимость, люди с психическими расстройствами)	[24, 33, 39, 61–70, 74–80, 82]

Раздел первой редакции	Что изменено во второй редакции	Основание
Модели и рекомендации	Модели внедрения заменены десятью операционными сценариями с указанием классов; предложения помечены как рекомендации автора	—
Риски и экономика	Сняты взаимоисключающие утверждения о затратах; приведены зарубежные данные и иллюстративная арифметика с петербургскими тарифами	[15, 53, 61, 82]
Приложения	Образцы положения, модели меню и чек-лист не воспроизводятся (доклад не содержит раздаточных материалов); добавлены реестр актов с классами, полная таблица норм № 1284 и перечень изменений	—